KARLSTADS UNIVERSITET

Att konstruera organisatoriska utmaningar: En studie av problemformulering i politiskt styrd hälso- och sjukvård

Constructing organizational challenges: A study of problem formulation in politically governed health care system

Ghazal Paivandi

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningsprogram: Statsvetarprogrammet

Nivå/Högskolepoäng: 15 hp

Handledarens namn: Michaela Padden

Examinatorns namn: Caroline Karlsson

Datum: 2026-06-15

Förord

Denna uppsats har genomförts inom ramen för statsvetarprogrammet vid Karlstads universitet och markerar avslutningen på min kandidatutbildning. Arbetet med studien har varit både utmanande och lärorikt, och har gett mig en fördjupad förståelse för hur organisatoriska frågor inom hälso- och sjukvården kan analyseras ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till de intervjupersoner som generöst har delat med sig av sina erfarenheter och insikter. Utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig. Era berättelser har varit avgörande för att förstå de komplexa utmaningar som präglar verksamheten i praktiken.

Jag vill även tacka min handledare Michaela för värdefull vägledning, konstruktiv feedback och stöd genom hela processen. Ditt engagemang och dina synpunkter har varit betydelsefulla för uppsatsens utveckling.

Slutligen vill jag tacka min omgivning, familj, vänner och närstående- för ert tålamod, stöd och uppmuntran under arbetets gång. Ert stöd har varit en viktig förutsättning för att kunna genomföra denna studie.

Karlstad, Maj 2026



Abstract

Healthcare is often described as a sector characterized by resource shortages, high workloads, and structural challenges. At the same time, the understanding of these problems is shaped by organizational structures, governance, and the perspectives of different actors. Previous research has largely focused on identifying problems within healthcare, while less attention has been paid to how these problems are formulated and understood by different actors within the organization.

The aim of this study is to examine how problems within healthcare are understood and shaped by different actors within the organization. The study specifically focuses on how problems are constructed in relation to actors' different positions and experiences within the organization.

The study is based on a qualitative research design in which semi-structured interviews were conducted with six participants from different parts of healthcare services, including assistant nurses, unit managers, and trade union representatives. The empirical material was analyzed using thematic analysis. The theoretical framework consists of organizational theory perspectives, New Public Management, Street-Level Bureaucracy, and theories of collaboration and responsibility allocation.

The findings show that organizational problems are not understood uniformly but are shaped differently depending on actors' organizational positions, responsibilities, and experiences. Resource shortages, staffing issues, workload, organizational governance, and collaboration challenges emerged as recurring themes in the empirical material. The findings further indicate that organizational problems are rarely described as isolated phenomena, but rather as consequences of the interaction between organizational structures, governance systems, and the practical conditions of everyday work.

The study also demonstrates that organizational problems are closely linked to issues of power and legitimacy, where different actors have varying opportunities to influence which problems receive attention and which solutions are perceived as possible. The conclusion is therefore that organizational problems within politically governed healthcare cannot be understood as objective or neutral phenomena, but must instead be understood in relation to organizational structures, governance arrangements, and the perspectives of different actors.

Keywords: organizational problems, healthcare, governance, Street-Level Bureaucracy, New Public Management, organizational theory, qualitative study

Innehållsförteckning

1. Inledning **1**
1.1 Bakgrund 3
1.1.1 Välfärdsstaten och hälso- och sjukvårdens organisering 3
1.1.2 Demografiska förändringar i Sverige 3
1.1.3 Organisatoriska utmaningar inom hälso- och sjukvården 4
1.1.4 Styrning och politiska mål 5
1.1.5 Lokal kontext: Karlstads kommun 6
1.2 Problemformulering 7
1.3 Syfte och frågeställningar 8
1.4 Disposition 8
2. Tidigare forskning **10**
2.1 Arbetsmiljö och arbetsbelastning 10
2.2 Organisatorisk styrning och struktur 11
2.3 Organisationskultur och ledarskap 12
2.4 Forskningslucka 13
2.5 Studiens bidrag 14
3. Teoretiska utgångspunkter **15**
3.1 Organisationsteoretiska perspektiv 15
3.2 Styrning och New Public Management 16
3.3 Street-Level Bureaucracy 17
3.4 Samverkan och ansvarsfördelning 18
4. Metod och material **20**
4.1 Forskningsdesign 20
4.2 Urval och tillvägagångssätt 21
4.3 Datainsamlingsmetod 23
4.3.1 Intervjuguide 24
4.3.2 Intervjugenomförande 25
4.4 Bearbetning av intervjumaterial 25
4.4.1 Tematisk analys 25
4.5 Etiska överväganden 28
4.6 Dataskyddsförordningen (GDPR) 29
4.7 Studiens tillförlitlighet 29
5. Resultat och analys **31**
5.1 Resurs- och bemanningsproblem 31
5.2 Arbetsbelastning och arbetsmiljö 33
5.3 Organisation och samverkan 34
5.4 Styrning i relation till praktik 35
5.5 Kompetens och kvalitet 37
5.6 Strukturella och politiska faktorer 38
6. Slutsatser, diskussion och förslag till framtida forskning **40**

6.1 Slutsatser 40
6.2 Diskussion 41
6.3 Begränsningar och förslag till framtida forskning 42
Referenser **44**
Bilaga 1- Informationsbrev 47
Bilaga 2 - Intervjuguide 48
Bilaga 3 - Kodningsschema 50

1. Inledning

Att arbeta inom hälso- och sjukvård innebär att dagligen möta människor i några av deras mest utsatta stunder. Bakom varje arbetsuppgift finns människor med behov av trygghet, stöd och omsorg, samtidigt som personalen själva arbetar under höga krav, begränsad tid och ständiga organisatoriska förändringar. För många patienter handlar vården om känslan av att bli sedd, lyssnad på och bemött med värdighet. För vårdpersonalen handlar arbetet samtidigt om att försöka upprätthålla denna trygghet inom ramen för en verksamhet som ofta präglas av hög arbetsbelastning, personalbrist och organisatoriska begränsningar (SKR, 2025). Bakom diskussioner och effektivitet, resurser och organisering finns en mer grundläggande mänsklig oro - rädsla för att en dag själv bli beroende av ett vårdsystem som inte har tid, resurser eller möjlighet att möta människors behov av trygghet och värdighet.

Inom den offentliga debatten beskrivs vården återkommande som pressad. Berättelser om långa vårdköer, stressad personal och bristande resurser har blivit en allt vanligare del av samhällsdiskussionen. Samtidigt riskerar dessa beskrivningar att reducera vårdens problem till frågor om ekonomi, effektivitet och bemanning, utan att fullt ut synliggöra hur problemen faktiskt upplevs och förstås av människor som arbetar inom verksamheten. Organisatoriska problem handlar därmed inte enbart om brist på resurser, utan också om hur arbetet organiseras, vilka krav som ställs och vilka erfarenheter som ges utrymme inom verksamheten.

Hälso- och sjukvården är dessutom en komplex och politiskt styrd verksamhet där ansvar delas mellan stat, region och kommun (SKR, 2025). Verksamheten bygger på samverkan mellan flera olika professioner och organisatoriska nivåer, samtidigt som arbetet påverkas av styrning, budgetprioriteringar och krav på effektivitet. Under de senaste decennierna har offentlig sektor i allt större utsträckning präglats av styrningsideal kopplade till mätbarhet, resultat och effektivisering, vilket påverkat hur vårdens verksamheter organiseras och styrs. Samtidigt består vård och omsorg av relationsbaserat arbete som ofta är svårt att standardisera och mäta, vilket kan skapa spänningar mellan krav och personalens praktiska erfarenheter (Lipsky, 2016).

Det som definieras som ett problem är därför inte självklart eller neutralt. Ett problem som från ledningshåll förstås som en fråga om effektivitet och resursfördelning kan av vårdpersonal uppfattas som en fråga om arbetsmiljö, tidspress eller bristande möjligheter att ge god vård. Problemen formuleras därmed i relation till olika aktörers perspektiv, erfarenhet

och positioner inom verksamheten. Samtidigt är dessa problemformuleringar nära kopplade till makt, då olika aktörer har olika möjligheter att påverka vilka problem som uppmärksammas, vilka erfarenheter som ges legitimitet och vilka lösningar som framstår som möjliga inom verksamheterna (Bolman & Deal, 2025).

Genom att analysera intervjuer med vårdpersonal, enhetschefer och fackliga representanter syftar studien till att bidra med en fördjupad förståelse för relationen mellan organisatoriska strukturer, styrning och problemformulering inom politiskt styrd hälso- och sjukvård.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Välfärdsstaten och hälso- och sjukvårdens organisering

Den svenska välfärdsstaten har vuxit fram successivt och bygger på principen om att staten har ett ansvar för medborgarnas välfärd. Under 1800-talet började olika former av sociala trygghetssystem utvecklas, exempelvis genom lokala försäkringskassor och fattigvård. Under 1900-talet institutionaliserades dessa system och utvecklades till ett mer omfattande välfärdssystem med universella rättigheter (Norén Bretzer, 2022, s. 70-71).

Under efterkrigstiden expanderade välfärdsstaten kraftigt, där hälso- och sjukvård, socialförsäkringar och äldreomsorg byggdes ut i syfte att säkerställa ekonomisk och social trygghet för hela befolkningen. Den svenska modellen kännetecknas av skattefinansiering och en relativt hög grad av omfördelning, där resurser fördelas efter behov snarare än betalningsförmåga (Norén Bretzer, 2022, s. 71).

Den svenska hälso- och sjukvården är organiserad genom ett delat ansvar mellan stat, region och kommun. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar staten för lagstiftning och övergripande styrning, medan regionerna ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård till befolkningen. Kommunerna ansvarar för äldreomsorg och delar av hemsjukvården (Hälso- och sjukvårdslag 2017:30). Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller övergripande mål och riktlinjer för hur vården ska organiseras och bedrivas. Målet med vården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska även vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet (Socialstyrelsen, 2020).

Denna ansvarsfördelning innebär samtidigt att vården är beroende av samverkan mellan flera olika aktörer och verksamheter, vilket kan skapa organisatoriska utmaningar i praktiken. Särskilt inom äldreomsorg och akutsjukvård ställs höga krav på kommunikation, samordning och tydlig ansvarsfördelning mellan olika verksamheter och yrkesgrupper.

1.1.2 Demografiska förändringar i Sverige

Sverige står inför betydande demografiska förändringar som påverkar välfärdens organisering och hälso- och sjukvårdens framtida förutsättningar. Befolkningen har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och uppgick år 2025 till cirka 10.6 miljoner invånare (SCB, 2026a). Samtidigt förändras befolkningens åldersstruktur, där andelen äldre ökar i takt med att medellivslängden stiger och födelsetalen minskar. SCB:s befolkningspyramid visar tydligt

hur Sveriges befolkning blivit allt äldre över tid. Bland de äldre åldersgrupperna finns dessutom fler kvinnor än män, vilket främst beror på att kvinnor generellt lever längre (SCB, 2026b). Befolkningspyramiden visar även att de stora generationerna födda under 1940-talet nu befinner sig i de äldre åldersgrupperna, vilket innebär att antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt under kommande år.

Samtidigt ökar antalet personer i arbetsför ålder i samma takt som den äldre delen av befolkningen. Detta innebär att färre personer förväntas försörja en växande grupp av äldre, vilket leder till en ökad demografisk försörjningsbörda (SCB, 2026a). Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver att de demografiska förändringarna leder till ökade krav på framför allt äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Samtidigt står välfärden inför betydande utmaningar kopplade till kompetensförsörjning och bemanning, då behovet av personal ökar i takt med att fler äldre behöver vård och omsorg (SKR, 2025).

1.1.3 Organisatoriska utmaningar inom hälso- och sjukvården

Den svenska hälso- och sjukvården står inför flera omfattande organisatoriska utmaningar som påverkar både verksamhetens effektivitet och kvalitet. En central utmaning rör kompetensförsörjning och bemanning. Flera aktörer lyfter att det är svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens, vilket skapar en pressad arbetssituation i vården. Bristen på personal innebär att verksamheter i högre grad blir beroende av tillfällig bemanning, vilket kan påverka kontinuiteten och samordningen i vårdarbetet. Samtidigt bidrar detta till en ökad arbetsbelastning för den ordinarie personalen (Ström, 2022).

Utöver bemannings problematiken präglas hälso- och sjukvården av organisatoriska brister kopplade till struktur och samordning. Vårdsystemet är komplext och uppdelat mellan olika huvudmän, där regioner ansvarar för hälso- och sjukvården och kommuner för äldreomsorg och delar av hemsjukvården. Detta kan leda till samordningsproblem och bristande kontinuitet för patienten, särskilt i övergångar mellan olika vårdformer. Bristande samverkan mellan aktörer lyfts som en återkommande utmaning, vilket försvårar ett helhetsperspektiv på vården (Furmark & Malin, 2023, s. 5-6).

Vidare finns utmaningar kopplade till resursanvändning och effektivitet. Trots att Sverige satsar på stora resurser på hälso- och sjukvård visar analyser att systemet präglas av låg produktivitet i relation till insatta resurser, samt långa vårdköer och bristande tillgänglighet. Detta tyder på att resurserna inte alltid används på ett optimalt sätt, vilket skapar behov av organisatoriska förändringar och effektiviseringar (Furmark & Malin, 2023, s. 4-5). En

ytterligare central utmaning rör den demografiska utvecklingen. Detta skapar ett strukturellt tryck på vårdsystemet, där färre personer ska försörja och arbeta inom en sektor med ökande behov. I kombination med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar innebär detta att vården står inför långsiktiga krav på omställning, nya arbetssätt och ökad effektivitet (Furmark & Malin, 2023, s. 12).

Sammanfattningsvis kan de organisatoriska utmaningarna inom hälso- och sjukvården förstås som en kombination av bemanningsproblem, bristande samordning, resurs utmaningar och demografiska förändringar. Dessa faktorer samverkar och förstärker varandra, vilket gör att vården står inför behovet av både strukturella och organisatoriska förändringar för att kunna möta framtidens krav.

1.1.4 Styrning och politiska mål

Den svenska hälso- och sjukvården är en politiskt styrd verksamhet där ansvar och styrning delas mellan staten, regionerna och kommunerna. Staten ansvarar för lagstiftning och övergripande nationella mål, medan regionerna ansvarar för att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård. Kommunerna ansvarar samtidigt för äldreomsorg samt delar av hemsjukvården och den kommunala vården (SKR, 2025). Styrningen av vården sker genom lagar, riktlinjer, budgetar och olika former av styrdokument. En central utgångspunkt för svensk hälso- och sjukvård återfinns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), där det framgår att målet med vården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska vara av god kvalitet, tillgänglig och bygga på respekt för människors lika värde.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) regleras hälso- och sjukvården genom flera olika lagar och nationella styrinstrument, samtidigt som regioner och kommuner har ett relativt stort ansvar för hur verksamheten organiseras i praktiken. Detta innebär att vårdens organisering präglas av både nationell styrning och lokal självständighet (SKR, 2025). Samtidigt har den statliga styrningen av vården ökat under senare år genom fler nationella krav, riktade statsbidrag och uppföljningssystem. SKR beskriver att denna utveckling har lett till en ökad detaljstyrning av regioner och kommuner, vilket i vissa fall kan skapa svårigheter för verksamheterna att anpassa arbetet efter lokala behov och förutsättningar. Det finns därför en pågående diskussion om balansen mellan nationell styrning, lokal självständighet och verksamheternas praktiska möjligheter att uppnå politiskt uppsatta mål (SKR, 2025).

Styrningen av hälso- och sjukvården handlar därmed inte enbart om resursfördelning och organisation, utan även om hur politiska mål och styrdokument omsätts i praktiken inom

vårdens vardagliga verksamhet. Detta är särskilt relevant i relation till frågor om arbetsbelastning, tillgänglighet, kvalitet och organisatoriska prioriteringar inom vård och omsorg.

1.1.5 Lokal kontext: Karlstads kommun

Karlstads kommun utgör en central del av Värmlands regionala utveckling och är den största kommunen i länet. Kommunen präglas av en relativt stark befolkningstillväxt jämfört med övriga delar av Värmland, vilket innebär både möjligheter och utmaningar för välfärdsverksamheten. Samtidigt som Karlstad växer står många andra kommuner i regionen inför en minskande och åldrande befolkning, vilket skapar en obalans i resursfördelning och behov inom vård och omsorg (Region Värmland, 2025; Regionfakta, 2025). På regional nivå framhålls demografiska förändringar, kompetensförsörjning och ökade krav på välfärdstjänster som centrala utmaningar för kommuner och regioner (Region Värmland, 2025). Dessa utmaningar blir särskilt tydligt inom äldreomsorgen, där efterfrågan på insatser ökar i takt med att befolkningen blir äldre.

Den lokala debatten i Karlstad och Värmland visar att organisatoriska frågor inom äldreomsorgen är återkommande och omdiskuterade. Flera artiklar i lokalpressen lyfter problem kopplade till arbetsmiljö, bemanning och organisering av hemtjänsten (NWT, 2025; NWT, 2026). Bland annat diskuteras hur omsorgsarbete är svårt att planera i detalj, trots styrning och schemaläggning, samt hur arbetsbelastningen påverkar personalens möjligheter att utföra sitt arbete. Samtidigt framgår det att organisatoriska förändringar ofta framställt som genomförda i politiska sammanhang. I den lokala debatten betonas exempelvis att minutstyrningen inom hemtjänsten har avskaffats i syfte att förbättra arbetsmiljön och stärka kontinuiteten för omsorgstagarna (NWT, 2025). Denna typ av beskrivning illustrerar hur problem och lösningar formuleras i politiska och administrativa kontexter, där fokus ofta ligger på åtgärder och förbättringsarbete.

Vidare sker styrningen av vård och omsorg i Karlstad inom ramen för ett flernivåsystem där ansvar delas mellan stat, region och kommun. Denna ansvarsfördelning kräver samverkan mellan olika aktörer, vilket i praktiken kan innebära utmaningar i form av samordning och tydlighet i ansvar (Norén Bretzer, 2021, ss. 27-29). Sammanfattningsvis delar den lokala kontexten i Karlstad att organisatoriska utmaningar inom vård och omsorg inte enbart handlar om resurser eller demografi, utan även om hur verksamheten styrs, organiseras och beskrivs. Detta gör Karlstad till ett relevant fall för att studera hur organisatoriska problem uppfattas och formuleras i praktiken.

1.2 Problemformulering

Hälso- och sjukvården beskrivs ofta som en verksamhet i kris. I både politisk debatt och offentlig diskussion återkommer berättelser om personalbrist, hög arbetsbelastning, vårdköer och bristande resurser. Organisatoriska problem inom exempelvis inom vård och omsorg framställs därmed ofta som självklara och objektiva problem som främst handlar om ekonomi, bemanning eller effektivitet. Samtidigt riskerar sådana beskrivningar att dölja en mer grundläggande fråga: vem har egentligen makten att definiera vad som räknas som ett organisatoriskt problem inom vården?

Vad som uppfattas som ett problem inom en organisation är inte neutralt. Organisatoriska problem formas genom styrning, strukturer och olika aktörers perspektiv och erfarenheter. Ett problem som av ledning och styrning förstås som en fråga om effektivitet och resursanvändning kan av personal inom verksamheten uppfattas som en fråga om arbetsmiljö, tidspress eller bristande förutsättningar att utföra arbetet på ett hållbart sätt. På så sätt handlar organisatoriska problem inte enbart om vilka problem som existerar, utan också om vilka problem som uppmärksammas, vilka perspektiv som ges legitimitet och vilka erfarenheter som riskerar att osynliggöras.

Under de senaste decennierna har offentlig sektor i allt större utsträckning präglats av styrningsidéer kopplade till New Public Management (NPM), där fokus på effektivitet, resultat och mätbarhet fått en allt större betydelse inom offentlig verksamhet (Karlsson, 2017, ss. 27-30). Inom hälso- och sjukvården har detta inneburit att organisatoriska problem i högre grad förstås genom språk kopplat till prestation, produktivitet och resursanvändning. Samtidigt präglas vård och omsorg av relationsbaserat och komplext arbete som ofta är svårt att standardisera och mäta. Detta skapar spänningar mellan organisatoriska krav på effektivitet och personalens praktiska erfarenheter av verksamheten. I offentlig debatt framträder samtidigt olika och ibland konkurrerande problemformuleringar kring vårdens organisatoriska utmaningar, där frågor om styrning, administration och professionellt handlingsutrymme ställs mot krav på effektivitet och resultat (Helander, 2022). Frågan blir därmed inte enbart vilka organisatoriska problem som finns inom vården, utan också vilka perspektiv som ges tolkningsföreträde i förståelse av verksamhetens utmaningar.

Parallellt kännetecknas hälso- och sjukvården av organisatorisk komplexitet där ansvar delas mellan flera professioner, verksamheter och organisatoriska nivåer (SKR, 2025, s. 2-3). Samverkan framställs ofta som en central förutsättning för att verksamheten ska fungera effektivt, men forskning och styrdokument visar samtidigt att ansvarsfördelning och

koordinering mellan olika verksamheter ofta präglas av gränsdragningar och otydlighet (SKR, 2025, s. 3). Organisatoriska problem uppstår därmed inte enbart inom enskilda verksamheter, utan även i gränssnittet mellan olika organisatoriska nivåer, professioner och styrningsformer.

Mot denna bakgrund undersöker studien hur organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården förstås och formuleras av olika aktörer inom verksamheten, samt hur styrning, strukturer och ansvarsfördelning påverkar dessa problemformuleringar. Genom att analysera hur organisatoriska problem ges mening i praktiken syftar studien till att bidra med en fördjupad förståelse för relationen mellan styrning, organisation och problemformulering inom politiskt styrd hälso- och sjukvård.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur organisatoriska utmaningar inom hälso- och sjukvården förstås och formuleras av olika aktörer inom verksamheten. Studien fokuserar särskilt på hur organisatoriska problem konstrueras i relation till styrning, strukturer och aktörers olika positioner och erfarenheter inom verksamheten.

För att uppfylla detta syfte utgår studien från följande frågeställningar:

- Hur konstruerar och formulerar olika aktörer organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården?
- Hur påverkar organisatoriska strukturer, styrning och ansvarsfördelning olika aktörers problemformuleringar?
- Vilka likheter och skillnader finns mellan olika aktörers beskrivningar och förståelser av organisatoriska problem inom verksamheten?

1.4 Disposition

Uppsatsen är delad i sex kapitel. I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar. Här introduceras även studiens relevanta samt de centrala utgångspunkterna som ligger till grund för undersökningen. Det andra kapitlet behandlar tidigare forskning om organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på forskning kring styrning, arbetsbelastning, samverkan och organisatoriska utmaningar inom offentlig verksamhet. Kapitlet syftar även till att identifiera den forskningslucka som studien avser att bidra till.

I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk. Här behandlas teorier om organisation och styrning, New Public Management, Street-level Bureaucracy samt samverkan och ansvarsfördelning. Teorierna används som analytiska verktyg för att förstå hur organisatoriska problem formuleras och förstås inom verksamheten. Det fjärde kapitlet presenterar studiens metod och forskningsdesign. Här presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, val av metod, urval, datainsamling, analysmetod samt forskningsetiska överväganden och metodkritik.

I det femte kapitlet presenteras studiens resultat och analys. Här analyseras intervjumaterialet utifrån studiens teoretiska ramverk med fokus på hur organisatoriska problem förstås, beskrivs och formuleras av olika aktörer inom verksamheten. Det sjätte och avslutande kapitel sammanfattar studiens huvudsakliga resultat och diskuterar dessa i relation till tidigare forskning, teori och studiens syfte. Kapitlet innehåller även avslutande reflektioner samt förslag på vidare forskning.

2. Tidigare forskning

Detta kapitel syftar till att ge en översikt av tidigare forskning om organisatoriska utmaningar inom hälso- och sjukvården. Forskningen presenteras utifrån tre centrala områden: arbetsmiljö och arbetsbelastning, organisatorisk styrning och struktur samt organisationskultur och ledarskap. Dessa teman speglar olika dimensioner av hur vårdens organisation fungerar i praktiken och vilka utmaningar som kan uppstå inom verksamheten.

Inledningsvis behandlas forskning om arbetsmiljö och arbetsbelastning, där fokus ligger på hur organisatoriska faktorer påverkar personalens arbetsförhållanden. Därefter behandlas forskning om organisatorisk styrning och struktur, med särskilt fokus på hur styrningsformer och organisatoriska processer påverkar arbetets organisering. Vidare presenteras forskning om organisationskultur och ledarskap, där betydelsen av samarbete, kommunikation och ledning lyfts fram.

Avslutningsvis identifieras en forskningslucka, där kapitlet visar att tidigare forskning i stor utsträckning fokuserar på att identifiera organisatoriska problem, medan mindre uppmärksamhet riktas mot hur dessa problem formuleras, förstås och hanteras i praktiken.

2.1 Arbetsmiljö och arbetsbelastning

Arbetsmiljö och arbetsbelastning framträder i tidigare forskning som återkommande problemområden inom hälso- och sjukvården. Hansen, Sverke och Näswall (2008) genomför en studie av arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress inom vårdsektorn, där de analyserar sambandet mellan organisatoriska krav och individens välbefinnande. Författarna diskuterar särskilt hur förändringar i arbetsorganisation och styrning påverkar arbetsmiljön. Resultatet visar att hög arbetsbelastning i kombination med begränsade resurser utgör en central faktor bakom stress och utbrändhet (Hansen, Sverke & Näswall, 2008, s. 12-13). De Hert (2020) presenterar även en översikt av utbrändhet inom hälso- och sjukvården och analyserar de faktorer som bidrar till fenomenets utbredning. Studien behandlar bland annat arbetsbelastning, tidspress och organisatoriskt stöd. Resultatet visar att vårdpersonal är särskilt utsatt för utbrändhet, vilket kan få konsekvenser både för individen och för vårdens kvalitet (De Hert, 2020, s. 171-172).

Även Bergström och Ellberg (2021) analyserar utvecklingen inom hälso- och sjukvården och visar att ökade krav på effektivitet och kvalitet, i kombination med begränsade resurser, har bidragit till en mer pressad arbetssituation för vårdpersonal. Författarna framhåller att organisatoriska faktorer såsom bemanning, resurstillgång och inflytande över arbetet är

avgörande för att skapa en hållbar arbetsmiljö (Bergström & Ellberg, 2021, s. 3-6). Denna bild bekräftas även av Arbetsmiljöverket (2023), där det visar sig att en stor andel av de anställda inom vård och omsorg upplever en alltför hög arbetsbelastning. Problemet är särskilt utbrett inom dessa sektorer, vilket indikerar att arbetsmiljöutmaningar är strukturella snarare än individuella.

Sammantaget visar tidigare forskning att arbetsmiljö och arbetsbelastning inom hälso- och sjukvården är nära kopplade till organisatoriska förutsättningar. Kombinationen av höga krav och begränsade resurser bidrar till en pressad arbetssituation, vilket påverkar såväl arbetsmiljön som kvaliteten i vården. [1] Forskningen ger viktiga insikter i hur vårdpersonalen upplever utmaningar inom verksamheten. Däremot riktas mindre fokus mot hur dessa problem ges mening och förstås olika beroende på aktörernas position, ansvar och perspektiv.

2.2 Organisatorisk styrning och struktur

Tidigare forskning visar att organisatorisk styrning inom hälso- och sjukvården har betydande konsekvenser för hur arbetet organiseras och genomförs i praktiken. Brunton och Lawn (2026) genomför en kvalitativ studie av vårdledares perspektiv inom äldreomsorgen på utredningar av allvarliga vårdincidenter, där dessa utredningar analyseras som centrala styrningsverktyg inom organisationen. Dessa processer framställs som viktiga styrningsmekanismer inom vården, där krav på ansvarstagande, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling samverkar (Brunton & Lawn, 2026, ss. 153-154).

Resultatet visar samtidigt att dessa styrningsprocesser är förenade med verksamhetsrelaterade problem. Utredningar beskrivs som resurskrävande och arbetsintensiva, där personal ofta behöver omfördelas från ordinarie arbetsuppgifter för att genomföra dem. Detta skapar en ökad arbetsbelastning och påverkar verksamhetens kapacitet (Brunton & Lawn, 2026, s. 158-159). Vidare framhålls att processerna präglas av omfattande administrativa krav och styrningsstrukturer, vilket bidrar till en ökad komplexitet inom verksamheten (Brunton & Lawn, 2026, s. 161-162).

Forskningen pekar även på att styrningsprocesser inte alltid leder till de förbättringar som avses. Brunton & Lawn (2026) visar att rekommendationer från utredningar ofta upprepas och att liknande problem återkommer över tid, vilket tyder på begränsat verksamhetsutveckling (Brunton & Lawn, 2026, s. 159-160). Detta indikerar att styrning

[1] Litteratursökningen för denna del genomfördes i databaser såsom Google Scholar och Sociological Collection, där sökord som “workload”, “burnout”, “healthcare” och “organizational factors” användes. Urvalet av studier baserades på relevans för hälso- och sjukvårdens organisatoriska utmaningar.

inom hälso- och sjukvården inte enbart bidrar till kontroll och kvalitetssäkring, utan även kan skapa ineffektivitet och svårigheter i att omsätta kunskap till praktisk förändring. Denna bild bekräftas även i bredare analyser av svensk hälso- och sjukvård. Forska Sverige (2026) framhåller i en rapport att organisatoriska strukturer och bristande samordning utgör centrala hinder för utveckling och implementering av nya arbetssätt inom vården.

Forskningen visar att organisatorisk styrning och struktur påverkar hur hälso- och sjukvården organiseras och fungerar. Samtidigt kan dessa styrningsformer bidra till utmaningar kopplade till resursanvändning, arbetsbelastning och verksamhetsutveckling.[2] Forskningen visar därmed att styrning inte enbart handlar om att skapa struktur och effektivitet, utan också påverkar vilka problem som uppmärksammas inom verksamheten och vilka lösningar som framstår som legitima. Samtidigt behandlas styrning ofta som ett administrativt verktyg snarare än som en process där olika aktörer har olika möjligheter att påverka hur problem definieras och förstås.

2.3 Organisationskultur och ledarskap

Organisationskultur och ledarskap skapar viktiga förutsättningar för hur verksamheter inom hälso- och sjukvården organiseras och fungerar i praktiken. Utöver formella strukturer och styrningsmodeller påverkas arbetet i hög grad av informella normer, värderingar och relationer mellan olika yrkesgrupper. Dessa faktorer påverkar hur samarbete fungerar, hur problem hanteras samt hur ansvar fördelas inom organisationen. Kiptulon et al. (2024) visar i en systematisk litteraturöversikt att organisationskultur har en direkt påverkan på vårdpersonalens arbetsrelaterade stress. Studien identifierar att negativa organisatoriska faktorer, såsom brist på stöd från ledningen, otillräckliga resurser och otydliga roller bidrar till ökad stress och försämrade arbetsförhållanden (Kiptulon et al., 2024, s. 2-3). Dessa resultat indikerar att arbetsmiljöproblem i hög grad är kopplade till organisatoriska och ledarskaprelaterade faktorer, snarare än enbart individuella förhållanden.

Dessutom framhålls att organisationskulturen påverkar hur samarbete och kommunikation fungerar inom vårdteamet. En kultur som präglas av bristande kommunikation och svagt organisatoriskt stöd kan leda till konflikter, otydlighet och ökad arbetsbelastning (Kiptulon et al., 2024, s. 3). Denna bild bekräftas även i senare forskning. Wright et al. (2026) undersöker sambandet mellan teamklimat, arbetstillfredsställelse och kulturell förståelse kan leda till

[2] Litteratursökningen för denna del genomfördes i databasen Scopus, där sökord som “Healthcare governance” användes. Urvalet baserades på studier som behandlar organisatorisk styrning och ledning inom hälso- och sjukvården. Sökningen avgränsades till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed) och urvalet baserades på studier som behandlar organisatorisk styrning och ledning inom hälso- och sjukvården.

kommunikationsproblem och konflikter inom vårdteamet. Vilket i sin tur påverkar både arbetsmiljö och vårdkvalitet (Wright et al., 2026, s. 4-5). Samtidigt visar resultaten att ett positivt teamklimat, präglat av öppen kommunikation, tillit och samarbete bidrar till ökad trivsel och en starkare vilja att stanna kvar i organisationen (Wright et al., 2026, s. 5-6).

Ledarskapets betydelse lyfts särskilt fram i forskningen. Ett stödjande och tydligt ledarskap bidrar till att skapa struktur, främja kommunikation och säkerställa att personalen har tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete. Samtidigt visar studier att bristande stöd från ledningen kan förstärka arbetsrelaterad stress och försämra arbetsmiljön (Kiptulon et al., 2024, s. 3-4). Sammantaget visar tidigare forskning att dessa faktorer påverkar inte enbart arbetsmiljö och trivsel, utan också hur organisatoriska problem uppstår, hanteras och reproduceras inom verksamheten. [3] Däremot riktar tidigare forskning mindre fokus mot hur olika aktörer själva tolkar och konstruerar problem inom verksamheten, samt hur vissa perspektiv ges större legitimitet än andra i organisatoriska sammanhang.

2.4 Forskningslucka

Tidigare forskning visar tydligt att vårdens verksamheter präglas av hög arbetsbelastning, resursbrist, samordningssvårigheter och ökade organisatoriska krav som påverkar både personalens arbetsförhållanden och verksamhetens kvalitet. Studierna bidrar även med viktiga insikter kring hur vårdpersonal upplever utmaningar och hur dessa påverkar det dagliga arbetet inom verksamheten.

Samtidigt riktas mindre uppmärksamhet mot hur problem definieras, prioriteras och tolkas av olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Detta innebär därmed att det finns begränsat kunskap om hur olika aktörer, exempelvis vårdpersonal, chefer och fackliga representanter, kan förstå och formulera problem på olika sätt beroende på deras position, ansvar och erfarenheter inom verksamheten.

Vidare problematiserar tidigare forskning i begränsad utsträckning hur makt, styrning och strukturer påverkar vilka problem som ges legitimitet och vilka perspektiv som får större genomslag inom organisatoriska och politiska sammanhang. Frågan om vad som definieras som ett organisatoriskt problem handlar därmed inte enbart om organisatoriska brister i sig,

[3] Litteratursökningen för denna del genomfördes i databasen Scopus, där sökord som “healthcare organizational culture” och “leadership healthcare” användes. Sökningen avgränsades till vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed) och urvalet baserades på studier som behandlar organisationskultur och ledarskap inom hälso-och sjukvården.

utan också om vilka aktörer som har möjlighet att påverka hur problemen förstås och vilka lösningar som framstår som möjliga inom verksamheten.

Utifrån detta identifieras en forskningslucka kring hur problem konstrueras och formuleras i praktiken inom politiskt styrd hälso- och sjukvård. Denna studie indikerar därför till att bidra med en fördjupad förståelse för hur utmaningar förstås och tolkas av olika aktörer inom verksamheten.

2.5 Studiens bidrag

Denna studie bidrar med en fördjupad förståelse för hur problem inom hälso- och sjukvården förstås av olika aktörer. Genom att undersöka perspektiv från olika arbetsgrupper synliggör studien hur organisatoriska problem kan uppfattas och beskrivas olika beroende på aktörernas positioner. Studien bidrar även till forskning om offentlig styrning och organisation genom att belysa hur makt, styrning och strukturer påverkar vilka problem som uppmärksammas och ges legitimitet.

3. Teoretiska utgångspunkter

Syftet med detta kapitel är att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens analys. Genom att använda organisationsteoretiska perspektiv, teorier om styrning samt Street-level bureaucracy skapas en analytisk ram för att förstå hur organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården uppstår och formuleras i praktiken. Vidare behandlas samverkan och ansvarsfördelning som centrala aspekter i en verksamhet där flera aktörer samverkar. Tillsammans bidrar dessa teoretiska perspektiv till att belysa hur strukturer, styrning och praktiska förutsättningar samspelar i skapandet av organisatoriska utmaningar.

3.1 Organisationsteoretiska perspektiv

Inom organisationsteorin betonas vikten av att analysera organisationer utifrån flera perspektiv för att skapa en mer nyanserad förståelse av hur verksamheter fungerar i praktiken. Enligt Lee Bolman och Terrence Deal (2025) kan organisationer förstås genom olika analytiska perspektiv som belyser skilda dimensioner av organisatoriskt liv. Författarna utgår från att organisationer kan analyseras genom fyra centrala perspektiv: det strukturella, det Human- Resource, det politiska och det symboliska perspektivet (Bolman & Deal, 2025, s. 21-24). Dessa perspektiv kompletterar varandra och möjliggör en mer nyanserad förståelse av organisationens komplexitet. I denna studie är särskilt det strukturella och det politiska perspektivet centrala, då de möjliggör en analys av hur organisatoriska problem formas både genom formella strukturer och genom makt- och intresseprocesser inom organisationen.

Det strukturella perspektivet utgår från att organisationer formas genom formella arrangemang såsom arbetsdelning, regler, hierarkier och ansvarsfördelning. Strukturen kan ses som organisationens “arkitektur”, vilket både möjliggör och begränsar handlande inom verksamheten (Bolman & Deal, 2025, s. 74). En central aspekt är relationen mellan differentiering och integrering, där arbetsuppgifter delas upp samtidigt som verksamheten kräver samordning mellan olika enheter (Bolman & Deal, 2025, s. 94). Brister i denna balans kan leda till organisatoriska problem, exempelvis i form av otydligt ansvar, samordningssvårigheter och ineffektivitet. Samtidigt visar organisationsteorin att formella strukturer inte fullt ut kan förklara hur organisationer fungerar i praktiken. Det politiska perspektivet betonar istället att organisationer består av aktörer med olika intressen, värderingar och mål, vilket gör organisationer till arenor för makt och konflikter (Bolman & Deal, 2025, s. 220). Organisatoriska processer handlar därmed inte enbart om rationell

problemlösning, utan också om förhandlingar och prioriteringar mellan konkurrerande intressen.

En central utgångspunkt inom det politiska perspektivet är att beslut ofta rör fördelning av knappa resurser, såsom tid, personal och ekonomiska medel (Bolman & Deal, 2025, s. 220-221). Detta innebär att konflikter är en naturlig del av organisationers funktion, snarare än ett undantag. I denna kontext blir makt en avgörande faktor, då olika aktörer försöker påverka vilka problem som uppmärksammas och vilka lösningar som prioriteras. Makt förstås här inte enbart som formell auktoritet, utan som en resurs som kan utövas genom exempelvis kontroll över information, expertkunskap och tillgång till beslutsprocesser (Bolman & Deal, 2025, s. 229-231). Detta innebär att inflytande i organisationer inte nödvändigtvis sammanfaller med formella positioner, utan även formas genom informella relationer och strategiska handlingar. Vidare betonas att organisatoriska mål inte är fasta eller entydiga, utan växer fram genom förhandlingar mellan olika aktörer (Bolman & Deal, 2025, s. 224-225). Detta innebär att det som definieras som ett organisatoriskt problem inte är objektivt givet, utan resultatet av hur olika aktörer tolkar och formulerar situationen utifrån sina intressen och positioner.

Sammantaget visar dessa organisationsteoretiska perspektiv att organisatoriska problem inte enbart kan förstås som tekniska eller administrativa brister. I stället formas de i ett samspel mellan formella strukturer och politiska processer, där makt, resurser och tolkningar påverkar hur problem uppstår, definieras och hanteras. Detta är centralt för denna studie, då fokus ligger på hur organisatoriska utmaningar uppfattas och formuleras i praktiken inom hälso-och sjukvården.

3.2 Styrning och New Public Management

Styrning utgör en central del av hur offentliga organisationer organiseras och fungerar, särskilt inom hälso- och sjukvården där verksamheten är politiskt reglerad. Under de senaste decennierna har styrningen i offentlig sektor i stor utsträckning präglats av idéer kopplade till New Public Management (NPM), vilket inneburit en förändrad syn på hur offentlig verksamhet bör styras och organiseras (Karlsson, 2017, s. 27-28). New Public Management kan förstås som ett samlingsbegrepp för en rad olika reformer snarare än en enskild förändring (Karlsson, 2017, s. 31, 34). Detta bekräftas även av Christopher Hood, som beskriver NPM som ett brett och relativt löst begrepp som används för att sammanfatta en uppsättning administrativa doktriner som dominerat reformarbetet i många OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)-länder. (Hood, 1991).

Enligt Hood (1991) kännetecknas NPM av ett antal centrala principer, däribland ökad betoning på resultatstyrning, mätbara prestationer och ett tydligare ansvarstagande genom ledningens kontroll över verksamheten (s. 4-5). Detta innebär att styrningen förskjuts från processer till uppnådda resultat, där verksamheter i större utsträckning utvärderas utifrån uppnådda resultat snarare än hur arbetet genomförs (Karlsson, 2017, s. 224-225). Vidare lyfter Hood (1991) fram att NPM innebär en uppdelning av tidigare sammanhållna organisationer i mindre enheter, ökad konkurrens samt en större användning av styrningsprinciper hämtade från den privata sektorn (s. 5-6). Dessa reformer syftar till att skapa mer effektiva och styrbara organisationer, där ansvar och prestation kan följas upp på ett tydligare sätt.

I relation till hälso- och sjukvården innebär dessa styrningsprinciper att verksamheter i högre grad organiseras utifrån mål, uppföljning och mätbara resultat. Detta kan skapa incitament att definiera och hantera problem i termer av effektivitet, resursanvändning och prestation. Samtidigt kan mer svårmätbara aspekter, såsom arbetsmiljö, samverkan och kvalitet i omsorgen vara svårare att fånga inom dessa styrningssystem (Hood, 1991, s. 4-5; Karlsson, 2017, s. 15-16). NPM bygger i stor utsträckning på ett fokus på effektiv resursanvändning, som kopplas till administrativa värden där frugalitet och kostnadskontroll står i centrum (Hood, 1991, s. 11-12).

Detta kan leda till att styrningen i hög grad orienteras mot att minska kostnader och öka produktiviteten, vilket kan påverka hur verksamheten organiseras och vilka problem som uppmärksammas. Inom vård och omsorg kan denna typ av styrning bidra till ökad arbetsbelastning och begränsat handlingsutrymme för personalen, särskilt i verksamheter där arbetet är svårt att standardisera och mäta. Samtidigt visas att denna typ av styrning innebär en prioritering av vissa värden framför andra, där fokus på effektivitet kan stå i konflikt med exempelvis rättvisa och långsiktig hållbarhet (Hood, 1991, s. 13-15)

3.3 Street-Level Bureaucracy

Teorin om street-level bureaucracy (närbyråkrater), utvecklad av Michael Lipsky, utgör en central utgångspunkt för att förstå hur offentlig politik omsätts i praktiken. Enligt Lipsky definieras Street-level byråkrater som offentligt anställda som har direkt kontakt med medborgare och samtidigt ett betydande handlingsutrymme i utförandet av sitt arbete (Lipsky, 2016, s. 3-4). Dessa aktörer, såsom vårdpersonal, socialarbetare och andra yrkesgrupper inom välfärdssektorn, utgör i praktiken den nivå där statens politik realiseras. En central poäng i teorin är att dessa aktörer inte enbart implementerar policy, utan också i hög grad bidrar till

att forma den. Lipsky menar att deras individuella beslut tillsammans utgör den faktiska politiken, då det är genom deras handlingar som medborgare möter staten (Lipsky, 2016, s. 3-4). Detta innebär att policy inte enbart bestäms på en övergripande nivå, utan konstrueras i mötet mellan organisation och praktik.

Street-level byråkrater arbetar under särskilda arbetsvillkor som påverkar deras handlingsutrymme. Enligt Lipsky präglas deras arbete av begränsade resurser, hög arbetsbelastning och otydliga eller motstridiga mål (Lipsky, 2016, s. 27-30). Samtidigt är det ofta svårt att mäta prestation och resultat inom dessa verksamheter, vilket bidrar till osäkerhet kring vad som utgör ett "bra" arbete. Dessa villkor innebär att personalen i praktiken måste utveckla strategier för att hantera arbetets krav. Lipsky beskriver hur Street-level byråkrater använder olika former av förenklingar, prioriteringar och standardiseringar för att hantera stora arbetsmängder och begränsade resurser (Lipsky, 2016, s. 83-87). Dessa strategier är ofta nödvändiga för att arbetet ska fungera, men innebär samtidigt att verksamheten inte alltid genomförs i enlighet med formella riktlinjer.

En annan aspekt i teorin är handlingsutrymmet (discretion), vilket innebär att Street-level byråkrater har möjlighet att tolka och tillämpa regler i konkreta situationer (Lipsky, 2016, s. 13-15). Detta handlingsutrymme är svårt att eliminera, då arbetet ofta innebär komplexa och situationsbundna beslut som inte fullt ut kan standardiseras. Vidare betonar Lipsky att relationen mellan personal och överordnade nivåer ofta präglas av spänningar. Medan ledningen är inriktad på mål och resultat, är Street-level byråkrater i högre grad fokuserade på att hantera arbetsbelastningen och praktiska krav i det dagliga arbetet (Lipsky, 2016, s. 18-21). Detta kan leda till att riktlinjer tolkas eller anpassas utifrån lokala förutsättningar snarare än att följas strikt.

I relation till denna studie är teorin om Street-level bureaucracy relevant eftersom den möjliggör en analys av hur vårdpersonalen och andra aktörer inom vård och omsorg hanterar organisatoriska krav i praktiken. Teorin bidrar även till att förstå hur organisatoriska problem formas och tolkas i mötet mellan styrning, arbetsvillkor och det dagliga arbetet inom verksamheten.

3.4 Samverkan och ansvarsfördelning

Samverkan utgör en central del av hälso- och sjukvårdens verksamhet, särskilt i situationer där individer har behov av stöd från flera olika aktörer samtidigt. Inom svensk vård och omsorg delas ansvar mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter, vilket innebär att

verksamheten är beroende av koordinering och samarbete mellan flera organisatoriska nivåer (SKR, 2025, s. 2-3). Samtidigt framhålls att verksamheterna ofta har olika utgångspunkter, ansvar och förväntningar som kan skapa otydlighet kring ansvarsfördelning och samordning (SKR, 2025, s. 3). Dessa utmaningar kan förstås i relation till teorin om Street-level bureaucracy, där byråkrater arbetar under villkor som präglas av begränsade resurser, hög arbetsbelastning och motstridiga krav (Lipsky, 2016, s. 27-30). Under sådana organisatoriska förhållanden kan samverkan bli svår att upprätthålla, när olika verksamheter styrs av skilda mål, prioriteringar och organisatoriska krav.

SKR framhåller att effektiv samverkan förutsätter tydliga strukturer, etablerade kommunikationsvägar och överenskommelser mellan organisationer (SKR, 2025, s. 2, 7-8). I praktiken saknas ofta sådana strukturer, vilket kan leda till bristande koordinering mellan verksamheter. Detta innebär att ansvar inte alltid är tydligt definierat, särskilt i situationer där flera aktörer är involverade i en individs stöd och rehabilitering. En konsekvens av detta är att individer riskerar att “falla mellan stolarna”, då ingen enskild aktör har ett tydligt helhetsansvar (SKR, 2025, s. 3). Denna typ av problem uppstår inte nödvändigtvis inom enskilda organisationer, utan i övergångar mellan olika verksamheter och ansvarsområden.

Teorierna som benämns i kapitel 3 bidrar med olika analytiska ingångar till studiens undersökning av organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården. Organisationsteorin möjliggör en analys av hur organisatoriska strukturer, makt och intressen påverkar problemformuleringar inom verksamheten. Teorier om New Public Management används för att förstå hur styrning, effektivitet och resultatkrav påverkar vårdens organisering och vilka problem som uppmärksammas inom verksamheten. Street-Level Bureaucracy bidrar samtidigt till att analysera hur vårdpersonal och andra aktörer hanterar organisatoriska krav i praktiken. Tillsammans skapar teorierna ett analytiskt ramverk för att förstå hur organisatoriska problem tolkas och uppfattas inom politiskt styrd hälso- och sjukvård.

4. Metod och material

Syftet med detta kapitel är att redogöra för studiens metodologiska utgångspunkter samt de tillvägagångssätt som använts för att samla in och analysera empiriskt material. Kapitlet syftar till att skapa transparens kring forskningsprocessen och ge läsaren möjlighet att bedöma studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats, där semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod för att undersöka hur organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården uppfattas och formuleras i praktiken. Valet av metod är nära kopplat till studiens syfte, som är att skapa en fördjupad förståelse av aktörers erfarenheter och tolkningar snarare än att mäta eller generalisera fenomen.

Vidare presenteras urvalet av intervjupersoner samt hur datainsamlingen har genomförts. Kapitlet redogör även för hur intervjumaterialet har bearbetats och analyserats, samt vilka etiska överväganden som gjorts i samband med studiens genomförande. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och metodens styrkor och begränsningar.

4.1 Forskningsdesign

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsdesign där semistrukturerade intervjuer används som datainsamlingsmetod och tematisk analys används för att analysera det empiriska materialet. Fokus ligger på att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och erfarenheter. Enligt Bryman (2018) kännetecknas kvalitativ forskning av att tyngdpunkten ligger på ord snarare än kvantifierbara data, samt på tolkning av den sociala verkligheten (s. 454-455). Den kvalitativa metoden är särskilt lämplig i relation till studiens syfte, som är att undersöka hur organisatoriska problem inom hälso- och sjukvård och omsorg uppfattas och formuleras i praktiken. I stället för att mäta förekomsten av problem möjliggör metoden en fördjupad förståelse av hur dessa problem ges mening. Detta ligger i linje med den tolkningsinriktade (interpretativistiska) ansats som Bryman (2018) beskriver, där forskarens uppgift är att förstå hur individer själva tolkar sina sociala verklighet (s. 455). Eftersom studien har en tolkningsinriktad ansats är mitt fokus inte att fastställa vilka organisatoriska problem som objektivt existerar, utan att förstå hur olika aktörer inom verksamheten uppfattar, tolkar och beskriver dessa problem utifrån sina erfarenheter och positioner.

Vidare kan studien beskrivas som abduktiv, vilket innebär att analysen har präglats av ett växelspel mellan empiriskt material och teoretiska perspektiv. Utgångspunkten har varit

intervjupersonernas beskrivningar och erfarenheter av organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården, samtidigt som de teoretiska perspektiven har använts som analytiska verktyg för att tolka och förstå de mönster som framträtt i materialet. Analysen har därmed inte varit strikt teoristyrd, men inte heller induktiv, eftersom teorierna har bidragit till att fördjupa förståelsen av det empiriska materialet. Det abduktiva förhållningssättet har gjort det möjligt att växla mellan empiri och teori för att successivt utveckla tolkningar av hur organisatoriska problem förstås och formuleras av olika aktörer inom verksamheten. Kvalitativ forskning är inte en enhetlig metod, utan snarare en övergripande forskningsstrategi som omfattar flera olika tillvägagångssätt, exempelvis intervjuer, observationer och dokumentanalys (Bryman, 2018, s. 457). Denna studie operationaliseras den kvalitativa ansatsen genom semistrukturerade intervjuer, vilket möjliggör en systematisk men samtidigt flexibel datainsamling.

En central styrka med den kvalitativa metoden är dess förmåga att fånga komplexitet, kontext och processer. Detta är särskilt relevant i studier av organisationer, där problem inte enbart kan förstås som objektiva fenomen, utan som socialt konstruerade och beroende av aktörers tolkningar. Genom kvalitativa intervjuer skapas möjligheter att undersöka hur olika aktörer beskriver, tolkar och ger mening åt utmaningarna som finns i praktiken. Därför bidrar kvalitativ forskning en djupare förståelse för studiens undersökning (Bryman, 2018, .s 455). I denna studie innebär detta att organisatoriska problem förstås som något som formas i samspelet mellan exempelvis personal, ledning och styrning, snarare än som fasta och entydiga fenomen. Samtidigt finns begränsningar med den kvalitativa ansatsen. Eftersom studien baseras på ett mindre antal intervjuer är syftet inte att generalisera resultaten i statistisk mening. I stället ligger fokus på analytisk generalisering, där resultaten bidrar till en fördjupad förståelse av liknande organisatoriska sammanhang.

4.2 Urval och tillvägagångssätt

Urvalet i denna studie är strategiskt och består av sex intervjupersoner med erfarenhet från olika delar av vård- och omsorgsverksamheter. Urvalet inkluderar två undersköterskor inom hemtjänsten, där ena har mer än över 30 års yrkeserfarenhet och den andra 40 års yrkeserfarenhet. Dessutom har två enhetschefer från hemtjänsten samt akutmottagning intervjuats. Därutöver ingår två fackliga representanter från Kommunal, verksamma som sektionsföreträdare, försäkringsansvarig samt arbetsplats- och skyddsombud. Ett strategiskt urval innebär att forskaren medvetet väljer ut respondenter som bedöms vara särskilt relevanta för studiens syfte (Esaiasson et al., 2017, s. 269). I denna studie har urvalet gjorts

med utgångspunkt i att fånga olika organisatoriska perspektiv inom vård och omsorg, där både operativ personal, arbetsledning och fackliga företrädande inkluderas.

Intervjuperson	Befattning	Verksamhet
IP1	Undersköterska	Hemtjänst
IP2	Undersköterska	Hemtjänst
IP3	Enhetschef	Akutmottagning
IP4	Facklig representant	Kommunal
IP5	Facklig representant	Kommunal
IP6	Enhetschef	Hemtjänst

Tabell 1. Översikt över studiens intervjupersoner och deras organisatoriska positioner

För att säkerställa intervjupersonernas anonymitet benämns de fortsättningsvis som IP1-IP6. Tabellen ger en översikt över respondenternas organisatoriska positioner och verksamhetsområden.

Genom att inkludera dessa olika positioner möjliggörs en analys av organisatoriska problem ur flera nivåer inom organisationen. Undersköterskorna bidrar med erfarenheter från det dagliga arbetet, enhetscheferna med perspektiv på styrning och organisering, medan de fackliga representanterna bidrar med insyn i arbetsmiljöfrågor och strukturella problem inom verksamheten. Detta bidrar till en mer nyanserad och mångdimensionell förståelse av studiens forskningsområde. Urvalet kan även delvis förstås som ett nätverksbaserat urval, då vissa intervjupersoner identifierats genom kontakter. Detta innebär en potentiell begränsning, då det finns en risk att urvalet inte fullt ut representerar variationen inom verksamheten. Samtidigt har variation i yrkesroller och organisatoriska positioner eftersträvas för att minska denna risk.

Antalet intervjuer bedöms vara tillräckligt för att identifiera återkommande mönster i materialet, särskilt med tanke på studiens avgränsande syfte. Fokus ligger inte på generalisering i statistisk mening, utan på att skapa en fördjupad förståelse av hur organisatoriska problem upplevs och formuleras i praktiken. En fördel med ett begränsat antal intervjuer är att det möjliggör en mer djupgående analys av varje enskild respondents erfarenheter och resonemang. Detta ger utrymme för nyanserade tolkningar och en bättre förståelse av komplexa organisatoriska processer, vilket är centralt inom kvalitativ forskning.

Studien avgränsas till vård- och omsorgsverksamheter samt akutmottagningen inom Karlstads kommun och Region Värmland. Valet av dessa verksamheter grundar sig i studiens begränsade omfattning och möjligheten att inkludera aktörer från olika organisatoriska nivåer och funktioner. Syftet har inte varit att undersöka hela hälso- och sjukvården, utan studera hur organisatoriska problem förstås och formuleras inom utvalda delar av verksamheten. Genom att inkludera både kommunal vård och omsorg, akutsjukvård samt fackliga representanter möjliggörs en jämförelse mellan olika perspektiv och organisatoriska positioner.

En ambition i studiens inledande planering var även att inkludera politiska beslutsfattare för att fånga perspektiv från den politiska styrningsnivån. Detta bedömdes vara relevant eftersom studien behandlar organisatoriska problem inom en politiskt styrd verksamhet. På grund av studiens tidsmässiga ramar och begränsade möjligheter att genomföra ytterligare intervjuer var detta dock inte möjligt. Studien avgränsades därför till vårdpersonal, enhetschefer och fackliga representanter. Som tillsammans bidrar med perspektiv från olika organisatoriska nivåer inom verksamheten.

4.3 Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen i denna studie har genomförts genom semistrukturerade intervjuer. Denna metod är fördelaktig då den möjliggör en djupare förståelse för hur organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg uppfattas och formuleras av olika aktörer inom verksamheten. Genom att använda intervjuer ges möjlighet att fånga respondenternas egna erfarenheter, tolkningar och beskrivningar av organisatoriska utmaningar i praktiken. Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom de erbjuder en balans mellan struktur och flexibilitet. Metoden utgår från en intervjuguide, vilket skapar en viss kontroll över vilka teman som behandlas, samtidigt som det finns utrymme för följdfrågor och utvecklade resonemang (Esaiasson et al., 2017, s. 274). Detta innebär att intervjupersonerna ges möjlighet att uttrycka sina upplevelser med egna ord och lyfta aspekter som de själva uppfattar som relevanta för ämnet.

En ytterligare fördel med metoden är att den ger möjlighet att klargöra och fördjupa svar under intervjuns gång, vilket kan bidra till att minska risken för missförstånd (Esaiasson et al., 2017, s. 274). Detta är särskilt viktigt i studier som behandlar komplexa organisatoriska frågor, där begrepp och upplevelser kan tolkas på olika sätt. Samtidigt finns vissa begränsningar med metoden. En risk är att intervjun i hög grad kan komma att fokusera på vissa teman, vilket kan påverka bredden i materialet. Vidare kan samspelet mellan intervjuare och respondent påverka vilka svar som ges. I denna studie har intervjuguiden därför använts

som ett stöd för att säkerställa att samtliga relevanta teman behandlas, samtidigt som utrymme för flexibilitet har behållits.

Intervjupersonerna kontaktades via e-post där studiens syfte, upplägg och intervjuns omfattning presenterades genom ett informationsbrev (Se bilaga 1). I förfrågan informerades respondenterna om att intervjun var semistrukturerad, att deltagandet var frivilligt samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Intervjupersonerna gavs även möjlighet att själva välja tidpunkt och format för intervjun, vilket bidrog till att skapa en flexibel och anpassad intervjusituation. Detta tillvägagångssätt syftade till att underlätta deltagandet samt skapa goda förutsättningar för öppna och utförliga svar.

4.3.1 Intervjuguide

Intervjuguiden i denna studie har utformats i enlighet med principer för semistrukturerade intervjuer, där både innehåll och form beaktas. Enligt Esaiasson et al. (2017) bör intervjufrågor utformas så att de är lätta att förstå, öppna till sin karaktär och utformade för att uppmuntra intervjupersonen att utveckla sina svar (s. 274).

Tre separata intervjuguider utformades för olika respondentgrupper: vårdpersonal, enhetschefer och fackliga representanter. Guiderna anpassades efter respondenternas roll och erfarenheter, men utgick samtidigt från en gemensam tematisk struktur. De centrala teman som behandlades var resurs- och bemanningsproblem, arbetsbelastning och arbetsmiljö, organisation och samverkan, styrning i relation till praktik, kompetens och kvalitet samt strukturella och politiska faktorer.

Intervjuguiden byggdes upp i tre delar, i enlighet med metodlitteraturens rekommendationer. Inledningsvis ställdes så kallade uppvärmningsfrågor, där intervjupersonerna fick beskriva sin roll och yrkeserfarenhet. Syftet med dessa frågor var att skapa en trygg samtalssituation och etablera kontakt mellan intervjuare och respondent (Esaiasson et al., 2017, s. 274). Därefter följde tematiska frågor, där dessa frågor var öppet formulerade och syftade till att fånga intervjupersonernas egna upplevelser av problem inom verksamheten. Dessa typer av frågor, ofta benämnda som “grand tour”- frågor, ger respondenten möjlighet att utveckla sina resonemang och lyfta det som uppfattas som centralt inom det aktuella området (Esaiasson et al., 2017, s. 274-275).

För att fördjupa svaren användes även uppföljningsfrågor. Dessa kunde exempelvis handla om att be intervjupersonen ge konkreta exempel eller utveckla ett resonemang ytterligare. Uppföljningsfrågor är enligt Esaiasson et al. (2017) centrala för att få fram mer innehållsrika

och nyanserade svar (s. 275). Vid behov användes även mer direkta frågor för att beröra specifika aspekter som inte spontant togs upp av respondenten. Tolkande frågor användes i slutet av intervjun för att säkerställa att forskaren uppfattat respondentens svar korrekt. Dessa typer av frågor bör användas med försiktighet, då de annars riskerar att påverka respondentens egna formuleringar (Esaiasson et al., 2017, s. 275).

4.3.2 Intervjugenomförande

Respondenterna kontaktades i förväg och informerades om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt. Intervjuerna genomfördes vid tider som passade respondenterna, antingen digitalt eller på plats, och varade i cirka 30-40 minuter. Intervjuerna spelades in med samtycke och transkriberades i sin helhet. Under intervjuerna eftersträvades en öppen samtalssituation där respondenterna gavs möjlighet att utveckla sina svar. Enligt Esaiasson et al. (2017, s. 274-275) är denna flexibilitet för att få nyanserade och innehållsrika svar.

4.4 Bearbetning av intervjumaterial

Det insamlade intervjumaterialet transkriberades i sin helhet för att möjliggöra en tematisk analys. Transkriberingen resulterade i ett omfattande textmaterial på cirka 26 sidor. Materialet analyserades enligt Braun och Clarke (2006), med syfte att identifiera återkommande mönster och centrala teman i respondenternas utsagor.

Genom att strukturera materialet utifrån dessa teman möjliggjordes en systematisk jämförelse mellan olika respondenternas perspektiv. Analysen präglas samtidigt av ett tolkande förhållningssätt, vilket innebar att fokus inte enbart låg på vad personerna uttryckte, utan även på hur deras beskrivningar kunde förstås i relation till deras positioner, erfarenheter och förutsättningar. Kodningsschemats utformning och analysprocessens olika steg beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.4.2.

4.4.1 Tematisk analys

Det empiriska materialet analyserades genom tematisk analys. Enligt Braun och Clarke (2006) syftar tematisk analys till att identifiera, analysera och tolka återkommande mönster och teman i kvalitativa data. Analysmetoden valdes eftersom den erbjuder ett flexibelt tillvägagångssätt som lämpar sig väl för studier där fokus ligger på att undersöka erfarenheter, upplevelser och meningsskapande processer inom organisationer. Denna analysmetod valdes även eftersom studien syftar till att undersöka hur organisatoriska

problem förstås och formuleras av olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Därför möjliggör metoden därför en systematisk bearbetning av respondenternas utsagor samtidigt som utrymme ges för att identifiera skillnader och likheter mellan olika positioner och erfarenheter.

I denna studie användes tematisk analys för att identifiera återkommande problemformuleringar, mönster och skillnader mellan aktörernas beskrivningar av verksamhetens utmaningar. Analysen genomfördes med ett abduktivt arbetssätt, där teman utvecklades i nära relation till det empiriska materialet samtidigt som studiens teoretiska ramverk användes som analytiskt stöd vid tolkningen av resultaten. Analysen inspirerades av Braun & Clarkes (2006) sex steg för tematisk analys, vilket fungerade som ett metodologiskt stöd genom analysprocessen. De teman som identifierades växte fram ur intervjumaterialet, men analyserades och tolkades därefter med stöd av studiens teoretiska ramverk. Detta innebar att empiri och teori användes i samspel för att successivt utveckla förståelsen av hur organisatoriska problem formuleras och förstås av olika aktörer inom verksamheten.

4.4.2 Kodningsschema och kodningsprocess

Efter transkriberingen genomfördes en fördjupad genomläsning av intervjumaterialet för att skapa en övergripande förståelse för respondenternas beskrivningar, erfarenheter och problemformuleringar. Braun & Clarke (2006. s. 87-88) beskriver denna analysprocess som central inom tematisk analys, där forskaren genom upprepad genomläsning bekantar sig med materialet och börjar identifiera återkommande mönster och analytiskt relevanta delar av data. För att skapa struktur i analysarbetet skrevs både de transkriberade intervjuerna och intervjuguiderna ut i pappersformat, vilket möjliggjorde ett mer aktivt och överskådligt arbete med materialet.

Kodningsprocessen inleddes därefter genom manuell kodning av intervjumaterialet. Relevanta delar av respondenternas utsagor markerades med hjälp av färgkodning för att identifiera återkommande uttryck som relaterade till problem inom verksamheten. Braun & Clarke beskriver kodning som en process där forskaren systematiskt identifierar betydelsefulla delar av materialet och organiserar dessa för vidare analys (Braun & Clarke, 2006, s. 88-89). Kodningen utgick från studiens syfte, forskningsfrågor, intervjuguide samt studiens teoretiska utgångspunkter. Exempel på återkommande koder som identifierades var bemanningsproblem, arbetsbelastning, samverkan, ansvarsfördelning, styrning, kompetensförsörjning och resursbrist.

När den initiala kodningen genomfördes jämfördes respondenternas utsagor för att identifiera likheter, skillnader och återkommande mönster mellan olika perspektiv. Liknande koder grupperades därefter i bredare kategorier och potentiella teman, vilket Braun & Clarke beskriver som processen att söka efter teman genom att organisera koder i större meningsbärande mönster (2006, s. 79-80). Eftersom tidigare forskning redan identifierar flera organisatoriska utmaningar inom hälso- och sjukvården framträdde vissa teman relativt tydligt i materialet, samtidigt som analysen förblev öppen för nya mönster och problemformuleringar. Under processen markerades även citat som bedömdes illustrera återkommande problem och skillnader mellan aktörernas perspektiv eller framträdande utmaningar. Sedan användes dessa citat senare i analyskapitlet för att stärka analysens empiriska förankring.

Kodningsprocessen genomfördes iterativt, vilket innebar att koder, kategorier och teman kontinuerligt omprövas och utvecklas under analysens gång. Att granska och förfina teman bidrar till att säkerställa att de representerar sammanhängande och analytiskt relevanta mönster i materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 90-92). För att stärka analysens teoretiska ramverk, där organisationsteori, New Public Management och Street-Level Bureaucracy används som analytiska verktyg vid tolkningen av materialet. Det slutliga kodningsschemat presenteras i tabell 2.

Tema	Kod	Subkoder	Beskrivning
Resurs- och bemanningsproblem	Personalbrist	Underbemanning, rekryteringssvårigheter	Upplevelser av att det finns för lite personal i relation till arbetsuppgifter och svårigheter att täcka behov. Svårigheter att anställa ny personal
	Resursbrist	Ekonomi, vårdplatser	Begränsade resurser påverkar verksamheten
Arbetsbelastning och arbetsmiljö	Hög arbetsbelastning	Stress, tidsbrist, prioriteringar	Personal hinner inte med arbetsuppgifter
	Arbetsmiljö	Psykisk ohälsa, fysisk belastning	Påverkan på personalens hälsa

Organisation och samverkan	Bristande samarbete	Mellan professioner, mellan organisationer	Samverkansproblem inom och mellan verksamheter
Styrning och verklighet	Policy vs praktik	Orealistiska mål, minutstyrning	Skillnad mellan styrdokument och verklighet
	Ansvarsfördelning	Otydliga roller	Vem ansvarar för vad
Kompetens och kvalitet	Kompetensbrist	Oerfaren personal, brist på utbildning	Påverkar kvaliteten i vården
	Kvalitet i omsorg	Kontinuitet, patientsäkerhet	Hur vården påverkas
Strukturella och politiska faktorer	Demografi	Fler äldre, färre i arbete	Långsiktiga samhällsproblem
	Politisk styrning	Resursfördelning, mål	Hur politiska ambitioner påverkar verksamheten

Tabell 2, *Kodningsschema*

4.5 Etiska överväganden

Studien har genomförts med utgångspunkt i grundläggande forskningsetiska principer. Enligt Bryman (2018) är centrala etiska krav inom samhällsvetenskaplig forskning informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (s. 170-171). Samtidigt betonas att etiska överväganden inte bör förstås som fasta regler som kan "uppfyllas" i ett enskilt moment, utan som en kontinuerlig del av forskningsprocessen (Bryman, 2018, s, 170). I denna studie har etiska frågor därför inte enbart hanterats inför datainsamlingen, utan även under intervjuerna och i analysarbetet, där avvägningar kring exempelvis anonymisering och tolkning varit centrala. Informations- och samtyckes kraven aktualiseras särskilt i kvalitativa intervjuer, där det kan vara svårt att i förväg fullt ut beskriva studiens innehåll och möjliga konsekvenser. Ett "helt informerat samtycke" i praktiken är ofta svårt att uppnå, då forskningsprocessen kan utvecklas under arbetets gång (Bryman, 2018, s. 176). I denna studie har detta hanterats genom att ge deltagarna tydlig information om studiens syfte och upplägg, samtidigt som de under intervjun haft möjlighet att avstå från att besvara frågor eller avbryta sin medverkan.

Konfidentialitet och anonymitet har varit centrala, särskilt då studien behandlar arbetsrelaterade erfarenheter och organisatoriska problem. Dessa krav kan vara särskilt utmanande i kvalitativ forskning, där detaljerade beskrivningar riskerar att göra deltagare identifierbara (Bryman, 2018, s. 174-175). I denna studie har detta hanterats genom anonymisering av både personer och organisatoriska detaljer. Samtidigt innebär detta en avvägning, då anonymisering kan påverka analysens detaljnivå. Vidare aktualiseras frågan om potentiell skada för deltagarna. Bryman (2018) framhåller att forskare bör minimera risken för både fysisk och psykisk belastning, samt undvika att deltagare hamnar i utsatta situationer (s. 172-173). I denna studie har detta beaktats genom att intervjuerna genomförts i en respektfull och flexibel form, där deltagarna själva haft kontroll över hur mycket de velat dela med sig.

Sammantaget visar dessa överväganden att etiska principer i kvalitativ forskning inte enbart handlar om att följa riktlinjer, utan om att kontinuerligt göra avvägningar mellan forskningsintresse och deltagarnas integritet.

4.6 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter i denna studie har skett i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt Integritetsskyddsmyndigheten omfattar GDPR all behandling av personuppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande individ, inklusive ljudinspelningar och intervjumaterial (Integritetsskyddsmyndigheten, 2025). Eftersom studier bygger på kvalitativa intervjuer har särskild hänsyn tagits till respondenternas integritet och anonymitet. Intervjupersonerna informerades om studiens syfte, hur materialet skulle användas samt att deltagandet var frivilligt. Inspelat material och transkriberingar har behandlats konfidentiellt och endast använts inom ramen för studiens forskningsändamål. Vidare betonar GDPR att personuppgifter endast får behandlas för tydligt specificerade ändamål och inte lagras längre än nödvändigt (Integritetsskyddsmyndigheten, 2025). I denna studie innebär detta att allt intervjumaterial endast används för uppsatsens genomförande och kommer att raderas efter avslutat arbete.

4.7 Studiens tillförlitlighet

För att bedöma studiens tillförlitlighet används de kriterier som Bryman (2018) lyfter fram för kvalitativ forskning: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till konfirmering (s. 467).

Trovärdighet- För att stärka studiens trovärdighet har intervjuerna transkriberats ordagrant och analysen har genomförts systematiskt genom tematisk analys och ett tydligt kodningsschema. Vidare används citat från intervjupersonerna i resultat och analyskapitlet för att synliggöra kopplingen mellan respondenternas upplevelser och de tolkningar som görs (Bryman, 2018, s. 467). Genom att inkludera citat möjliggörs även för läsaren att följa hur slutsatserna har vuxit fram ur materialet. Studiens teoretiska ramverk och analytiska utgångspunkter redovisas dessutom öppet för att öka transparens kring hur materialet har tolkats.

Överförbarhet- avser i vilken utsträckning resultaten kan vara relevanta i andra sammanhang (Bryman, 2018, s. 467-468). Eftersom studien bygger på ett mindre strategiskt urval och fokuserar på organisatoriska problem inom specifika delar av hälso- och sjukvårdsverksamheten, är syftet inte att skapa statistisk generaliserbarhet. Istället eftersträvas en djupare förståelse av hur organisatoriska problem förstås och formuleras av olika aktörer inom verksamheten. Genom detaljerade beskrivningar av studiens kontext, urval och respondentgrupper skapas dock möjligheter för läsaren att själv bedöma resultatens relevans i andra organisatoriska sammanhang.

Pålitlighet- handlar om att forskningsprocessen ska vara tydligt beskriven och möjlig att följa (Bryman, 2018, s. 468). För att stärka studiens pålitlighet har metodbeskrivningen utformats detaljerat och kritiskt för att ge en detaljerad redogörelse för studiens genomförande, inklusive urvalsprocess, datainsamling, transkribering, kodning och analys. Kodningsschemat och beskrivningen av den tematiska analysprocessen syftar till att skapa transparens kring hur det empiriska materialet bearbetats och analyserats.

Möjlighet till konfirmering- handlar om att forskaren ska sträva efter att agera reflexivt och synliggöra hur egna tolkningar och utgångspunkter kan påverka forskningsprocessen (Bryman, 2018, s. 470). Eftersom studien bygger på kvalitativa intervjuer och tolkande analys är det inte möjligt att helt separera forskaren från analysprocessen. För att hantera detta har analysprocessen genomförts systematiskt och transparent. Genom att redovisa studiens teoretiska utgångspunkter samt använda empiriska citat har ambitionen varit att minska risken för att personliga antaganden påverkar tolkningarna.

5. Resultat och analys

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat och analys utifrån de teman som identifierats genom den tematiska analysen. Resultaten bygger på intervjupersonernas beskrivningar och erfarenheter av organisatoriska problem inom verksamheten. De empiriska resultaten analyseras därefter med stöd av studiens teoretiska ramverk för att skapa en djupare förståelse av hur organisatoriska problem förstås och formuleras av olika aktörer.

5.1 Resurs- och bemanningsproblem

Resurs- och bemanningsproblem framträder som ett genomgående och strukturellt tema i intervjumaterialet, där samtliga respondentgrupper beskriver hur brist på personal och resurser påverkar verksamhetens organisering, prioriteringar och kvalitet. Problematiken framstår inte enbart som en fråga om numerär bemanning, utan som en mer grundläggande obalans mellan organisatoriska krav och tillgängliga resurser. Flera intervjupersoner uttrycker att arbetsbelastningen överstiger den bemanning som finns tillgänglig, vilket skapar en situation där verksamheten kontinuerligt befinner sig i ett underskott av resurser. Samtidigt formulerar intervjupersonerna problematiken på olika sätt beroende på deras position och erfarenheter inom organisationen.

IP4 med erfarenhet av fackligt arbete uttrycker sig på följande sätt: [IP4] *"Det beror på dålig bemanning. Vi måste vara fler. Det är för många arbetsuppgifter på för lite personal."*Detta citat kan förstås som ett uttryck för en strukturell diskrepans mellan organisationens uppdrag och dess faktiska kapacitet. Snarare än att enskilda arbetsmoment brister, pekar uppfattningen på en mer systematisk problematik där arbetsmängden överstiger vad organisationen är dimensionerad för att hantera. I detta avseende blir teorin om Street-level bureaucracy central. Enligt Michael Lipsky kännetecknas frontlinjearbete av resursbrist i kombinatio med höga krav, vilket tvingar individer att utveckla strategier för att hantera arbetssituationen (Lipsky, 2016, s. 27-30). I intervjumaterialet framträder dessa strategier tydligt i form av prioriteringar och selektion av arbetsuppgifter. IP2 med erfarenhet från det dagliga arbetet uttrycker sig på följande sätt:

> [IP2] "Då får man prioritera. Man kanske måste hoppa över saker, som dusch, och planera om till senare. Man hinner inte alltid sitta ner och prata, eller diska. Men man ser alltid till att det viktigaste blir gjort – omvårdnad, medicin och mat. Det går först.

Här synliggörs hur organisatoriska begränsningar omsätts i praktiken genom att vissa delar av omsorgen nedprioriteras. Detta kan tolkas som ett exempel på hur Street-level bureaucracy, i

avsaknad av tillräckliga resurser, tvingas omdefiniera vad som är möjligt att genomföra inom ramen för sitt arbete. Prioriteringarna blir därmed inte individuella val, utan strukturellt betingade handlingar (Lipsky, 2016, s. 83-87). Vidare framkommer att resursbristen även påverkar den interna ansvarsfördelningen inom organisationen. IP1 delar detta med sig från jobbet:

> [IP1] "Vi som har jobbat länge får mycket mer ansvar. Vikarier har inte samma ansvar...Jag förstår att en helt ny vikarie inte kan ta ansvar direkt. Men de som har lite erfarenhet borde kunna ta mer ansvar. Det ska inte bara ligga på den fasta omsorgskontakten. Alla som går till kunden måste ha ett ansvar. Man måste ha en helhetssyn – att det är rent, snyggt och fungerar. Men den helhetssynen finns inte alltid.

Detta visar hur organisatoriska brister förskjuts nedåt i organisationen och internaliseras i arbetsgruppen. Ansvar koncentreras till mer erfarna medarbetare, vilket kan förstås som en informell lösning på strukturella problem. Ur ett Street-level perspektiv innebär detta att individers handlingsutrymme utvidgas, men under villkor som samtidigt ökar deras belastning och ansvar (Lipsky, 2016, s. 13-15).

Samtidigt pekar flera intervjupersonerna på att bemanningsproblematiken inte enbart är ett resultat av interna organisatoriska beslut, utan också av bredare större förändringar: [IP6]: *"Vi ser ju i forskningen och i demografin att befolkningen blir äldre. Man lever längre. Det kommer bli fler som behöver hjälp, samtidigt som vi får färre personer i arbetsför ålder."* Detta indikerar att resursproblematiken även är demografiskt betingad, vilket placerar den delvis utanför organisationens direkta kontroll. Här blir styrningsperspektivet relevant, där organisationer inom offentlig sektor förväntas hantera ökade behov inom ramen för begränsade resurser. Samtidigt förstås detta som ett uttryck för rekryteringsproblematik, där organisationen har svårt att tillgodose sitt personalbehov. Problemet handlar därmed inte enbart om nuvarande bemanning, utan om svårigheter att långsiktigt säkerställa tillgången på arbetskraft.

Ur ett New Public Management- perspektiv kan detta förstås som en konsekvens av en styrningslogik där effektivitet, kostnadskontroll och resursoptimering prioriteras (Hood, 1991, s. 4-5). En sådan styrning riskerar att leda till en bemanningsnivå som är anpassad efter ekonomiska ramar snarare än verksamhetens faktiska behov. Detta skapar i sin tur ett beroende av att personalen kompenserar för resursbristen genom ökad flexibilitet och anpassning i det dagliga arbetet.

5.2 Arbetsbelastning och arbetsmiljö

Arbetsbelastningen och arbetsmiljön framträder som ett centralt och mångdimensionellt tema i intervjumaterialet, och är nära sammankopplat med de resurs- och bemanningsproblem som identifierats i föregående avsnitt. Intervjupersonerna med erfarenhet av hemtjänsten beskriver en arbetssituation där höga krav kombineras med begränsade resurser, vilket resulterar i en arbetsmiljö präglas av fysisk och psykisk belastning. En återkommande aspekt i materialet är den mentala belastningen som följer arbetets ansvar och komplexitet:

> [IP1]: "Det är mycket att hålla koll på. Man försöker koppla av när man kommer hem, men jobbet är krävande. Och ja… det påverkar en psykiskt ibland. Det har hänt flera gånger under åren. [...] Det är mycket ansvar, mycket att tänka på hela tiden."

Citatet synliggör hur arbetsbelastningen inte enbart handlar om arbetsuppgifternas omfattning, utan även om det kontinuerliga ansvar och den kognitiva närvaro som arbetet kräver. Arbetsmiljön framträder därmed som en psykosocial belastning, där arbetet påverkar individen även utanför arbetstid. Detta kan tolkas som ett uttryck för en arbetssituation där återhämtningen försvåras, vilket riskerar att leda till långvarig stress och psykisk ohälsa. Samtidigt framkommer att arbetsbelastningen även har tydliga fysiska konsekvenser:

> [IP2]: "Det har varit mycket korttidsfrånvaro. Folk är slitna och trötta… inte utan anledning. Man kan ha ont i ryggen eller skadat sig, till exempel halkat på vintern. Man vet ju att jobbet är tungt. Om det hade varit lugnare pass dagen efter hade man kanske orkat jobba ändå."

Detta visar hur arbetsmiljöproblematiken sträcker sig bortom upplevd stress och även omfattar fysiska risker och belastningsskador. Korttidsfrånvaron framträder här som en konsekvens av arbetsvillkoren snarare än individuella faktorer, vilket pekar på en strukturell problematik där arbetsbelastningen över tid blir ohållbar. Liknande erfarenheter återkommer i intervjumaterialet, där arbetsbelastningen även kopplas till en känsla av otillräcklighet i det professionella utövandet:

> [IP5]: "Hög arbetsbelastning. Det vi kallar samhällsstress. Man känner att man inte hinner med. Man lämnar omsorgstagare och är inte nöjd med sin insats. Jag vill göra mer men jag hinner inte. Det tar väldigt mycket på en. [...] Rasism och okunskap påverkar arbetsmiljön mycket… det skapar oro och konflikter."

Här framträder en central dimension av arbetsmiljöproblematiken, där arbetsbelastningen inte enbart leder till stress, utan även till en upplevelse av att inte kunna leva upp till de krav och förväntningar som arbetet innebär. Arbetsmiljön präglas därmed av en moralisk spänning

mellan vad personalen anser vara god omsorg och vad som är möjligt att genomföra i praktiken. Detta bidrar till en känsla av frustration och otillräcklighet, vilket kan förstås som en konsekvens av motstridiga krav i arbetet (Lipsky, 2016, s. 27-30). Sociala relationer och maktförhållanden påverkar arbetssituationen. Arbetsmiljön formas därmed inte enbart av organisatoriska villkor, utan även av interaktioner mellan personal och omsorgstagare. Förekomsten av konflikter och diskriminerande beteenden bidrar ytterligare till en belastande arbetsmiljö, vilket förstärker den psykosociala stressen. Ur ett styrningsperspektiv kan dessa arbetsmiljöproblem förstås i relation till de organisatoriska ramar inom vilka verksamheten bedrivs. En styrningslogik präglad av effektivitet och kostnadskontroll riskerar att skapa en situation där arbetsbelastningen ökar utan motsvarande resurstillskott (Hood, 1991, s. 4-5). Detta innebär att personalen i praktiken får bära konsekvenserna av organisatoriska begränsningar, vilket påverkar både deras arbetsmiljö och möjligheten att utföra arbetet med önskvärd kvalitet.

Sammantaget visar resultaten att arbetsbelastning och arbetsmiljö inte kan förstås som isolerade eller individuella problem, utan som konsekvenser av de villkor som präglar verksamheten. Arbetsmiljön formas i ett samspel mellan organisatoriska krav, resurstillgång och sociala relationer, där personalens upplevelser av stress och otillräcklighet utgör viktiga uttryck för dessa förhållanden.

5.3 Organisation och samverkan

Samverkan mellan olika verksamheter beskrivs av intervjupersonerna som en återkommande utmaning i det dagliga arbetet. Till skillnad från tidigare teman, som främst berör interna arbetsvillkor, synliggör detta avsnitt hur problem uppstår i relationer mellan olika verksamheter, professioner och organisatoriska nivåer. Flera intervjupersoner beskriver att brister i samverkan påverkar det dagliga arbetet och skapar osäkerhet kring ansvarsfördelningen: [IP2]:*"Det är ofta oklart vem som ska göra vad… man får lösa det själv."* En annan upplevelse beskrivs på följande sätt:

> [IP1]: "Jag tänker så här… det är mycket det här med att det ska vara teamarbete mellan oss, sjuksköterskor och rehab. Men det tycker jag brister jättemycket fortfarande. Det väldigt mycket mejl…inte så mycket ögonkontakt eller direkt kontakt. Och det blir ju att man tappar samarbetet. Till exempel rehab- de gör sitt och skickar en vårdplan. Men de är inte med och visar hur det ska göras. "Där brister det jättemycket."

Detta visar att samverkan formellt sett finns där, men i praktiken präglas av bristande kommunikation och samordning. Trots att arbetet är organiserat som ett teamarbete, sker

interaktionen i hög grad genom indirekta kanaler, vilket försvårar ett fungerande samarbete. Detta kan förstås som en brist på integrering mellan olika delar av organisationen. Ur ett strukturellt perspektiv kan detta förstås som en obalans mellan differentiering och integrering. Enligt Bolman & Deal innebär arbetsdelning att olika professioner ansvarar för specifika uppgifter, men denna uppdelning kräver samtidigt fungerande samordning för att helheten ska fungera (Bolman & Deal, 2025, s. 94). I detta fall tyder intervjupersonerna på att samarbetet är otillräcklig, vilket leder till att arbetet fragmenteras snarare än integreras. Liknande erfarenheter framkommer, där respondenter beskriver en upplevelse av att arbeta isolerat från andra delar av verksamheten: [IP2]: *"Det känns som att vi jobbar ganska själva. Att de inte riktigt har koll på vår verklighet."*

Citatet pekar på en upplevd distans mellan olika verksamheter och professioner. Avsaknaden av gemensam förståelse för arbetsvillkoren bidrar till att samarbetet försvåras, vilket i sin tur påverkar både arbetsprocesser och ansvarsfördelning. Samarbetet framträder därmed inte som en integrerad arbetsprocess, utan någon som i stor utsträckning lämnas åt individen att hantera i praktiken. Avslutningsvis visar det sig att brister i samverkan leder till att ansvar blir otydligt, vilket i sin tur bidrar till att problem uppstår och förstärks i mötet mellan olika verksamheter.

5.4 Styrning i relation till praktik

I intervjumaterialet framträder hur styrningen tar form i det dagliga arbetet. Intervjupersonerna beskriver hur riktlinjer och beslut på en övergripande nivå inte alltid överensstämmer med de situationer som uppstår i mötet med omsorgstagare. Detta skapar en återkommande diskrepans mellan planerad verksamhet och praktiskt genomförande. Något som blir särskilt tydlig i relation till minutstyrning och planering inom hemtjänsten:

> [IP1]: "Det här med minutstyrning… Det sägs att det inte finns, men vi ser det hela tiden. Man har till exempel 12 minuter hos en brukare. Men ibland blir man kvar 50 minuter om något händer. Och då faller hela schemat. Man vet aldrig vad som väntar när man öppnar dörren. Det är det som gör jobbet svårt att planera."

Denna upplevelse illustrerar hur arbetet organiseras utifrån tidsbestämda insatser, trots att omsorgsarbetet i praktiken präglas av oförutsägbarhet. Den planeringslogik som styr verksamheten bygger på antaganden om att arbetet är förutsägbart och kontrollerbart, vilket står i kontrast till intervjupersonernas beskrivning av en vardag där behov och situationer varierar. Detta pekar på en grundläggande spänning mellan styrningens utformning och arbetets faktiska karaktär. En liknande problematik framträder i hur olika delar av omsorgen

ges utrymme inom organisationens styrning: [IP1]: [...]*"man kanske hinner prata med en omsorgstagare i fem minuter… men det räknas som trivseltid."*

IP1 synliggör i citatet hur vissa delar av omsorgsarbetet, särskilt de relationsbaserade, ges ett begränsat organisatoriskt värde inom verksamhetens styrning. Samtal, social kontakt och närvaro framträder i intervjumaterialet som viktiga delar av omsorgen, men samtidigt som aktivitet som inte fullt ut erkänns inom ett system präglat av tidsstyrning och mätbarhet. Det relationsskapande arbetet framstår därmed som något sekundärt i förhållande till de arbetsuppgifter som kan dokumenteras, tidsberäknas och följas upp organisatoriskt. På ett djupare plan synliggör citatet en konflikt mellan omsorgens mänskliga dimension och verksamhetens organisatoriska logik. Att samtal med omsorgstagare kategoriseras som "trivseltid" innebär inte enbart en administrativ uppdelning av arbetsuppgifter, utan speglar också hur olika delar av omsorgsarbetet värderas inom organisationen. Det som inte direkt kan mätas eller effektiviseras riskerar att få en underordnad position, trots att intervjupersonerna beskriver dessa delar som avgörande för kvaliteten i omsorgen.

Beskrivningen kan därmed förstås som ett uttryck för hur styrningsformer präglade av effektivitet och standardisering påverkar omsorgens innehåll och relationella karaktär. I praktiken skapas en arbetssituation där personalen förväntas prioritera mellan krav och mänskliga behov, vilket bidrar till en upplevelse av att omsorgens sociala och emotionella dimension successivt trängs undan. Resultatet blir inte enbart tidspress, utan en känsla av att det mänskliga mötet ges otillräckligt utrymme inom verksamhetens organisatoriska ramar.

Enligt New Public Management teori kan detta innebära att styrning i praktiken bidrar till att definiera vad som räknas som relevant arbete (Hood, 1991). Särskilt inom offentlig sektor där styrningen präglas av effektivitet, uppföljning och mätbarhet. I detta sammanhang blir även Street-Level Bureaucracy relevant. Frontlinjearbetare har en central roll i att omsätta styrning i praktiken, vilket innebär att de inte enbart implementerar beslut, utan också tolkar och anpassar dem utifrån den konkreta arbetssituationen (Lipsky, 2016, s. 13-15). När riktlinjer inte är fullt anpassade till verksamhetens villkor blir det personalens ansvar att hantera skillnaden mellan organisatoriska krav och omsorgens faktiska behov. Materialet från intervjun visar samtidigt att denna anpassning inte sker utan konsekvenser. Frontlinjearbetare blir därmed bärare av de spänningar som uppstår mellan styrningens fokus på det som mäts och den faktiska omsorgstagaren behov av flexibilitet, närvaro och social kontakt.

Sammanfattningsvis visar resultaten att styrning inte enbart påverkar hur arbetet organiseras, utan även vilka delar av omsorgen som ges organisatoriskt värde. Relationsskapande och

social närvaro riskerar att hamna i bakgrunden eftersom dessa delar är svårare att mäta och standardisera.

5.5 Kompetens och kvalitet

Frågor om kompetens och kvalitet framträder i intervjumaterialet som nära sammanlänkade med hur verksamheten organiseras, särskilt i relation till introduktion, arbetsvillkor och möjligheter till utveckling. Intervjupersonerna beskriver hur brister i dessa avseenden inte enbart påverkar personalens förutsättningar, utan även kvaliteten i omsorgen. En återkommande aspekt i materialet är hur nyanställda och vikarier introduceras i arbetet:

> [IP4]: [...] "till exempel hur unga och vikarier behandlas… det handlar mycket om okunskap. De får inte alltid bra introduktion. De har svårt att få fasta anställningar. Och de får inte alltid chans att utvecklas."

IP4 synliggör hur brister i introduktion och stöd påverkar personalens möjligheter att utveckla kompetens. Avsaknaden av strukturer för lärande och kontinuitet innebär att ny personal riskerar att arbeta utan tillräckliga kunskaper, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i omsorgen. Samtidigt pekar beskrivningen på en mer långsiktig problematik, där otrygga anställningsvillkor kan bidra till hög personalomsättning. Denna problematik framträder även i hur introduktionen av nya medarbetare är organiserad:

> [IP1]: "Det känns som att man ibland tar in folk direkt från gatan… introduktionen börjar i fel ände. Det viktigaste verkar vara telefonen- hur man loggar in och använder system. Men omvårdnaden, alltså det som är nära kunden, kommer senare. Kanske som tredje eller fjärde sak. Och det är för få introduktionsdagar – ofta bara två. Det är alldeles för lite."

Här synliggörs en prioriteringsproblematik där administrativa system och tekniska moment ges företräde framför omsorgens kärnuppgifter. Introduktionen framstår därmed som anpassad till organisationens behov av effektivitet och funktionalitet, snarare än till utveckling av yrkeskompetens. Detta kan få konsekvenser för hur arbetet utförs i praktiken, där fokus riskerar att förskjutas från omsorgens innehåll till dess organisering (Hood, 1991). När personal saknar tillräcklig erfarenhet eller stöd, ökar belastningen på mer erfarna medarbetare, vilket skapar en intern obalans i arbetsgruppen. Detta kan förstås som en självförstärkande process, där bristande kompetens bidrar till ökad arbetsbelastning, vilket i sin tur försvårar möjligheten att ge stöd till ny personal. Bristande kontinuitet och otillräcklig introduktion kan även påverka omsorgstagarens möjlighet att möta personal med tillräcklig erfarenhet och kunskap om individens behov.

När organisatoriskt stöd är begränsat, blir det upp till personal att själva utveckla strategier för att hantera arbetet (Lipsky, 2016, s. 83-87). Detta innebär att ny personal i högre grad tvingas “lära sig

genom att göra", vilket kan leda till variationer i hur omsorgen utförs. Kvalitet framträder därmed inte som en enhetlig standard, utan som något som formas i relation till individers erfarenheter. Vidare framkommer att hur personal behandlas inom organisationen har betydelse för verksamhetens långsiktiga stabilitet. Brister i introduktion och utvecklingsmöjligheter riskerar att påverka personalens vilja att stanna kvar, vilket i sin tur bidrar till fortsatt personalomsättning. Detta innebär att frågor om kompetens och kvalitet inte enbart är kopplade till kunskap, utan även till organisationens förmåga att skapa hållbara arbetsvillkor.

Resultaten visar att kompetens och kvalitet inte förstås som isolerade faktorer, utan även som resultat av hur verksamheten organiseras och styrs. Brister i introduktion, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter påverkar inte enbart personalens kompetens, utan även kvaliteten i omsorgen och verksamhetens långsiktiga funktion. Detta bidrar till att förstå hur problem reproduceras över tid, genom samspelet mellan bemanning, kompetens och arbetsvillkor.

5.6 Strukturella och politiska faktorer

Många av de utmaningar som upplevs i det dagliga arbetet förstås inte enbart som interna organisatoriska brister, utan även som konsekvenser av politiska prioriteringar, ekonomiska ramar och bredare samhälleliga förändringar. Problemen framträder därmed som nära sammanlänkade med hur vården styrs, prioriteras och resursfördelas på en övergripande nivå. En återkommande obalans beskrivs mellan politikernas mål och de resurser som finns tillgängliga för att uppnå dem: [IP5]: *"Politiker har höga ambitioner. Kvaliteten ska vara hög. Men samtidigt blir vi färre personal som ska utföra arbetet."*

Citatet pekar på en spänning mellan politiska ambitioner och verksamhetens praktiska förutsättningar. Kraven på kvalitet och tillgänglighet kvarstår samtidigt som personalresurserna upplevs minska, vilket innebär att ansvaret för att hantera denna obalans i praktiken förskjuts till personalen. Problemen framträder därmed inte enbart som frågor om individuella arbetsvillkor, utan som konsekvenser av resurser och ansvar fördelas inom välfärdverksamheten. Liknande erfarenhet framkommer i respondenternas beskrivningar av verksamhetens långsiktiga situation: [IP5]: [...] *"vi flyger lite på ångorna just nu."*

Detta uttryck förmedlar en upplevelse av att verksamheten befinner sig i ett tillstånd där marginalerna är mycket begränsade. IP5:s beskrivning antyder att verksamheten i stor utsträckning hålls samman genom personalens ansvarstagande och anpassningsförmåga snarare än genom stabila organisatoriska förutsättningar. Det tyder på normaliserade delar av verksamhetens vardag än tillfälliga avvikelser. IP3 beskriver samtidigt hur organisatoriska

mål och riktlinjer inte alltid är möjliga att genomföra utifrån verksamhetens faktiska förutsättningar:

> [IP3]: "Målen kan vara rimliga, men förutsättningarna att nå dem finns inte alltid. Till exempel isolering, det är rätt i teorin men vi har inte tillräckligt med rum. Då får man göra det mest rätta möjliga."

IP3, som arbetar inom akutmottagningen, beskriver en återkommande spänning mellan politiska ambitioner och verksamhetens praktiska villkor. Intervjupersonen ifrågasätter inte målen i sig, utan beskriver snarare hur begränsade resurser och organisatoriska förutsättningar påverkar möjligheten att genomföra dem fullt ut i praktiken. Uttrycket "det mest rätta möjliga" illustrerar hur enhetschefer, personal och ansvariga inom verksamheten kontinuerligt tvingas göra avvägningar mellan vad som är möjligt och vad som uppfattas professionellt eller etiskt önskvärt. Samtidigt finns en upplevd distans mellan beslutsfattande nivåer och den praktiska verkligheten: [IP5]: *"Politiker säger att det finns utmaningar. Men undersköterskan ute i hemtjänsten ser något helt annat."*

Enligt Bolman & Deal präglas organisationer av att olika aktörer har skilda intressen, värderingar och prioriteringar. Vilket innebär att organisationer fungerar som arenor för makt, konflikt och förhandling (Bolman & Deal, 2025, s. 220). Organisatoriska problem inom vård och omsorg kan därmed förstås som resultat av hur olika prioriteringar och värden vägs mot varandra, snarare än som neutrala eller objektiva tillstånd. Organisatoriska problem formas därmed i ett samspel mellan politiska beslut, ekonomiska ramar och verksamhetens praktiska villkor.

6. Slutsatser, diskussion och förslag till framtida forskning

6.1 Slutsatser

I detta delavsnitt besvaras studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie var att undersöka hur organisatoriska problem inom hälso- och sjukvården förstås och formuleras av olika aktörer inom verksamheten. Samtidigt undersöktes hur styrning, strukturer och ansvarsfördelningen kan påverka dessa problemformuleringar. Studien syftade även till att undersöka hur strukturella problem konstrueras i relation till olika aktörers positioner och erfarenheter inom verksamheten.

Studiens första frågeställning handlade om hur olika aktörer konstruerar och formulerar problem inom verksamheten. Utifrån analysen av det empiriska materialet dras slutsatsen att organisatoriska problem inte förstås på ett enhetligt sätt, utan att formas olika beroende på aktörernas position, ansvar och erfarenheter. Resultat visar att problem kopplade till resurser, bemanning, arbetsbelastning och strukturer återkommer hos samtliga aktörer, men att dessa problem ges olika betydelse beroende på vilken position de har inom verksamheten. Medan vissa aktörer beskriver problem utifrån arbetsmiljö och arbetsvillkor, tenderar andra att formulera problem i relation till styrning, organisering och resursfördelning.

Studiens andra frågeställning handlade om hur strukturer, styrning och ansvarsfördelning påverkar olika aktörernas problemformuleringar. Där visade resultatet att problem sällan förstås som isolerade fenomen, utan som konsekvenser av samspelet mellan verksamhetens praktiska förutsättningar. Analysen indikerar att styrning, administrativa krav och ansvarsfördelning påverkar hur problem uppmärksammas, prioriteras och hanteras inom verksamheten. Resultaten visar även att problem ofta uppstår i gränssnittet mellan olika verksamheter och nivåer inom organisationen, där otydligt ansvar och bristande samordning skapar ytterligare svårigheter inom verksamheten.

Studiens tredje frågeställning handlade om vilka likheter och skillnader mellan olika aktörers beskrivningar och förståelser av problem inom verksamheten. Resultaten visar att samtliga intervjupersoner beskriver att resursbrist, arbetsbelastning och organisatoriska utmaningar beskrivs som centrala problem inom verksamheten. Samtidigt framträder tydliga skillnader beroende på aktörernas positioner. Undersköterskorna fokuserar främst på hur problemen påverkar det dagliga arbetet och möjligheten att ge god vård och omsorg. Enhetscheferna betonar i större utsträckning organisatoriska förutsättningar, styrning och resursfördelning,

medan de fackliga representanterna i högre grad lyfter strukturella och politiska faktorer som bakomliggande orsaker till verksamhetens utmaningar. Resultaten indikerar därmed att problemen inte förstås på ett enhetligt sätt, utan formas i relation till aktörernas ansvar, erfarenheter och positioner inom organisationen.

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att problem inom politiskt styrd hälso- och sjukvård inte kan förstås som objektiva eller neutrala fenomen. Problemen formas och konstrueras i relation till strukturer, styrningsformer, olika erfarenheter och positioner. Studien visar därmed att problemen handlar inte enbart om vilka problem som finns inom verksamheten, utan också om vilka perspektiv och problemformulering som får genomslag inom organisationen.

6.2 Diskussion

I detta delavsnitt diskuteras studiens slutsatser i relationer till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning som visat att arbetsbelastning, resursbrist och krav utgör återkommande problem inom hälso- och sjukvården. I likhet med Hansen, Sverke och Näswall (2008), De Hert (2020) samt Bergström och Ellberg (2021) visar studien att hög arbetsbelastning och begränsade resurser påverkar personalens arbetsvillkor och möjligheter till att utföra sitt arbete. Samtidigt bidrar denna studie med ytterligare förståelse genom att visa att dessa problem inte enbart uppfattas som resursfrågor, utan också konstrueras och förstås olika beroende på aktörernas positioner. Studien bidrar därmed till att fylla den forskningslucka som identifierades i tidigare forskning genom att synliggöra hur problem formuleras och ges olika betydelser av aktörer på olika organisatoriska nivåer.

Resultaten stödjer även tidigare forskning om organisatorisk styrning och struktur. I likhet med Brunton och Lawn (2026) visar resultaten att styrningsprocesser och administrativa krav både kan skapa struktur och bidra till ökad komplexitet inom verksamheten. Studien indikerar samtidigt att styrning inte enbart påverkar hur verksamheten organiseras, utan också vilka problem som uppmärksammas och vilka lösningar som framstår som möjliga. Detta är särskilt relevant i en politiskt styrd verksamhet där flera olika nivåer och professioner samverkar.

Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv kan resultaten förstås genom samspelet mellan strukturer, makt och intressen. Bolman & Deals perspektiv bidrar till att förstå hur problem formas genom både formella strukturer och politiska processer. Resultaten bidrar samtidigt

till förståelsen av hur styrningsideal påverkar problemformuleringar inom verksamheten. Resultaten visar att problemen ofta beskrivs kopplat till effektivitet, resurser och prestation, vilket kan förstås till styrningsideal där produktivitet och resultat får stor betydelse. Samtidigt visar resultaten att denna typ av styrning ibland skapar spänningar mellan krav och förutsättningar. Därför är frågor om makt, legitimitet och tolkningsföreträde viktiga för att förstå varför vissa problem får större utrymme än andra inom politiskt styrd hälso- och sjukvård.

Studiens statsvetenskapliga relevans ligger i att den belyser hur organisatoriska problem inom offentlig verksamhet inte enbart kan förstås som frågor om resurser, bemanning eller arbetsbelastning. Resultaten visar även hur problemformuleringar formas genom styrning, ansvarsfördelning, maktrelationer och organisatoriska strukturer. Genom att undersöka hur olika aktörer tolkar och beskriver verksamhetens utmaningar bidrar studien till en ökad förståelse för hur problem konstrueras och ges legitimitet inom politiskt styrda organisationer. Studien bidrar därmed till forskning om offentlig styrning, organisation och policyimplementering genom att synliggöra relationen mellan politiska mål, organisatoriska förutsättningar och verksamhetens praktiska verklighet.

6.3 Begränsningar och förslag till framtida forskning

I detta delavsnitt presenteras studiens begränsningar samt förslag till framtida forskning. Begränsningarna diskuteras till studiens metodval, urval och empiriska avgränsningar. Samtidigt diskuteras möjliga utvecklingsområden för framtida forskning.

Det finns flera begränsningar i denna studie. En första begränsning rör studiens urval och omfattning. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med aktörer från olika delar av vård verksamheten. Även om variationen i respondentgrupper bidrar till flera djupa perspektiv innebär det begränsade urvalet att resultaten inte kan generaliseras statistiskt till hela hälso- och sjukvårdssektorn.

En andra begränsning handlar om urvalsprocessen. Delar av urvalet har genomförts genom nätverksbaserade kontakter, vilket kan ha påverkat vilka perspektiv som inkluderats i studien. Det finns därmed en möjlighet att vissa erfarenheter och problemformuleringar inte fångats inom ramen för undersökningen. Samtidigt har variation i de olika positionerna eftersträvats för att minska denna begränsning.

Ytterligare en begränsning är att studien huvudsakligen bygger på intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna möjliggör fördjupade beskrivningar av erfarenheter och

upplevelser, men fångar främst hur aktörer beskriver och tolkar problemen snarare än hur dessa uttrycks i praktiken. Observationer eller dokumentanalyser hade därför kunnat bidra med ytterligare perspektiv på hur problemen hanteras inom verksamheten. Vidare är studien avgränsad till specifika organisatoriska kontexter inom hälso- och sjukvården, vilket innebär att resultaten behöver förstås i relation till dessa sammanhang. Men problemen kan se olika ut beroende på olika delar av verksamheten och de professioner man befinner sig i.

Utifrån studiens resultat finns flera möjliga riktningar för framtida forskning. För det första vore det relevant att undersöka hur problem formuleras inom andra delar av vården, exempelvis primärvård, specialistvård, eller andra kommunala verksamheter, för att analysera om liknande mönster återkommer. För det andra skulle framtida forskning kunna inkludera flera organisatoriska nivåer, exempelvis politiker, högre tjänstepersoner eller beslutsfattare för att undersöka hur formuleringarna skiljer sig mellan strategiska och operativa nivåer. För det tredje skulle man kunna kombinera metoder, exempelvis intervjuer tillsammans med observationer eller dokumentanalyser, för att skapa en bredare förståelse.

Sammanfattningsvis visar studien behovet av fortsatt forskning om hur problem formas i relation till styrning, makt och strukturer, särskilt inom politiskt styrda verksamheter där flera aktörer och nivåer samspelar.

Referenser

Arbetsmiljöverket. (2023). *630 000 har alltid för hög arbetsbelastning – vanligast inom utbildning, vård och omsorg.*

Bergström, G., & Ellberg, C. (2021). *Arbetsmiljö i förändring: Om organisering och villkor i vård och omsorg.*

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2025). *Nya perspektiv på organisation och ledarskap* (6 uppl.). Studentlitteratur.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder* (3 uppl.). Liber.

De Hert, S. (2020). Burnout in healthcare workers: Prevalence, impact and preventative strategies. *Acta Anaesthesiologica Belgica*, 71(4), 171–183.

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., & Wängnerud, L. (2017). *Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad* (5 uppl.). Wolters Kluwer

Forska Sverige. (2026). *Agenda för hälsa och välstånd.*

Furmark, C., & Malin, M. (2023). *[Rapport om hälso- och sjukvårdens utmaningar]*. Svenskt Näringsliv. https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/qijiek_rapport_halso_och_sjukvard_webbpdf_1204885.html/Rapport_Halso_och_sjukvard_webb.pdf

Hansen, N., Sverke, M., & Näswall, K. (2008). *Utbrändhet i vården: Betydelsen av krav och resurser på tre sjukhus med olika driftsformer.*

Hood, C. (1991). *A public management for all seasons?* Public Administration, 69(1), 3–19.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30/

Integritetsskyddsmyndigheten. (2025, 23 september). *Dataskyddsförordningen (GDPR).* https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/

Karlsson, T. (2017). *New Public Management – ett nyliberalt 90-talsfenomen*. Studentlitteratur.

Kiptulon, J., et al. (2024). *Organizational culture and work-related stress among healthcare professionals: A systematic review.*

Lipsky, M. (2016). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (30th anniversary ed.)*. Russell Sage Foundation.

Norén Bretzer, Y. (2022). *Sveriges politiska system.* Studentlitteratur.

NWT. (2025). *Replik: Äldreomsorgen är en grundläggande del av välfärden.* https://www.nwt.se/2025/03/05/replik-aldreomsorgen-ar-en-grundlaggande-del-av-valfarden-c7b84/

NWT. (2026). *Kommunal går till Arbetsmiljöverket för hela hemtjänsten i Kils kommun – samma problem i varje arbetsplats.* https://www.nwt.se/2026/01/16/kommunal-gar-till-arbetsmiljoverket-for-hela-hemtjansten-i-kils-kommun-samma-problem-i-varje-arbe-b2a5d/

Region Värmland. (2025). *Region Värmlands utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård.* https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/om-regionen/om-region-varmland/styrande-dokument/region-varmlands-utvecklingsplan-for-framtidens-halso--och-sjukvard

Regionfakta. (2025). *Befolkningsutveckling i Värmland.* https://www.regionfakta.com/varmlands-lan/befolkning-och-hushall/befolkning/befolkningsutveckling-1805-2025/

SCB. (2026a). *Sveriges befolkning 2025.* https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/

SCB. (2026b). *Befolkningspyramid för* Sverige.https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspyramid-for-sverige/

Socialstyrelsen. (2020). *Hälso- och sjukvårdslagen – en översikt.*

Ström, M. (2022). *SKR: Fortsatt utmaning att hitta rätt kompetens till hälso- och sjukvården*. Läkartidningen.

https://lakartidningen.se/nyheter/skr-fortsatt-utmaning-att-hitta-ratt-kompetens-till-halso-och-sjukvarden/

Sveriges Kommuner och Regioner. (2025). *Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst.*

Sveriges Kommuner och Regioner. (2025). *Så styrs hälso- och sjukvården i Sverige.*

Wright, K., et al. (2026). *Team climate, job satisfaction, cultural competence and intention to stay among healthcare professionals.*

Bilaga 1- Informationsbrev

Hej (namn),

Jag heter Ghazal Paivandi och studerar statsvetenskap vid Karlstads universitet. Inom ramen för min kandidatuppsats genomför jag en studie om organisatoriska utmaningar inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på hur dessa uppfattas och hanteras i praktiken. Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur olika aktörer inom verksamheten upplever och formulerar organisatoriska problem, exempelvis i relation till arbetsvillkor, styrning och samverkan.

Jag vänder mig till dig som är verksam inom (XXX), då du har värdefull kunskap och insyn i personalens arbetsvillkor och verksamhetens utmaningar. Ditt deltagande skulle därför vara mycket betydelsefullt för studien.

Deltagandet innebär att du medverkar i en semistrukturerad intervju som beräknas ta 30-45 minuter. Intervjun kan genomföras digitalt eller på plats, beroende på vad som passar dig bäst. All medverkan är frivillig och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande utan att ange någon anledning. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och man har rätt till anonymitet. Det insamlade materialet kommer enbart att användas för denna studie och hanteras i enlighet med gällande dataskyddsregler (GDPR).

Om du har några frågor om studien är du varmt välkommen att kontakta mig. Stort tack för att du överväger att delta i studien.

Med vänliga hälsningar,

Ghazal Paivandi

Statsvetarprogrammet, Karlstads universitet

E-post:...

Bilaga 2 - Intervjuguide

Intervjuguide 1 - Hemtjänstpersonal

1. Kan du berätta om din roll och hur länge du har arbetat inom hemtjänsten?
2. Vilka problem upplever du som mest centrala i ditt arbete?
3. Hur påverkar dessa problem ditt dagliga arbete?
4. Hur skulle du beskriva arbetsbelastningen och bemanningen inom jobbet?
5. Hur påverkar detta ditt arbete med brukare?
6. Hur upplever du att ledningen beskriver problemen i verksamheten? Om det finns problem, hur brukar ledningen förklara dem? Vad säger de är orsaken?
7. Stämmer den bilden med din egen erfarenhet?
8. Hur väl stämmer beslut och riktlinjer med hur arbetet fungerar i praktiken?
9. Vem tycker du har mest inflytande över vilka problem som uppmärksammas?
10. Vem får ansvar när problem uppstår?
11. Vad tycker du behöver förändras för att förbättra situationen?

Intervjuguide 2 - Facket

1. Kan du berätta om din roll och hur länge du har arbetat inom facket?
2. Vilka organisatoriska problem upplever ni som mest återkommande inom verksamheten?
3. Hur kommer dessa problem till uttryck enligt medlemmarnas erfarenheter?
4. Vilka frågor kontaktar medlemmarna er ofast om?
5. Hur beskriver ni personalsituationen och arbetsbelastningen idag?
6. Hur upplever ni att ledningen eller kommunen beskriver problemen i verksamheten?
7. Delar ni den problembilden, eller ser ni andra orsaker?
8. Hur väl stämmer beslut, mål och styrdokument med hur verksamheten fungerar i praktiken?
9. Finns det problem som ni tycker inte uppmärksammas tillräckligt?
10. Vem upplever ni har störst inflytande över vilka problem som lyfts fram?
11. Vem får ansvar när problem uppstår?
12. Vad anser ni behöver förändras för att förbättra situationen?

Intervju enhetschef

1. Kan du berätta om din roll och hur länge du har arbetat inom verksamheten?
2. Vilka organisatoriska utmaningar upplever du som mest centrala inom hemtjänsten idag?
3. Hur påverkar dessa utmaningar verksamheten och det dagliga arbetet?
4. Hur skulle du beskriva personalsituationen och arbetsbelastningen inom verksamheten?
5. Vilka utmaningar finns när det gäller bemanning och kompetensförsörjning?
6. Hur arbetar ledningen med att hantera organisatoriska problem inom verksamheten?
7. Hur upplever du relationen mellan politiska beslut och verksamhetens praktiska förutsättningar?

8. Upplever du att styrdokument och beslut stämmer överens med verksamhetens verklighet i praktiken?
9. Finns det situationer där det uppstår skillnader mellan politiska ambitioner och det dagliga arbetet?
10. Hur upplever du att ansvar för organisatoriska problem fördelas inom verksamheten?
11. Vem upplever du har störst inflytande över vilka problem som uppmärksammas och prioriteras?
12. Vad anser du skulle behöva förändras för att förbättra verksamheten framöver?

Bilaga 3 - Kodningsschema

Tema	Kod	Subkoder	Beskrivning
Resurs- och bemanningsproblem	Personalbrist	Underbemanning, rekryteringssvårigheter	Upplevelser av att det finns för lite personal i relation till arbetsuppgifter och svårigheter att täcka behov. Svårigheter att anställa ny personal
	Resursbrist	Ekonomi, vårdplatser	Begränsade resurser påverkar verksamheten
Arbetsbelastning och arbetsmiljö	Hög arbetsbelastning	Stress, tidsbrist, prioriteringar	Personal hinner inte med arbetsuppgifter
	Arbetsmiljö	Psykisk ohälsa, fysisk belastning	Påverkan på personalens hälsa
Organisation och samverkan	Bristande samarbete	Mellan professioner, mellan organisationer	Samverkansproblem inom och mellan verksamheter
Styrning och verklighet	Policy vs praktik	Orealistiska mål, minutstyrning	Skillnad mellan styrdokument och verklighet
	Ansvarsfördelning	Otydliga roller	Vem ansvarar för vad
Kompetens och kvalitet	Kompetensbrist	Oerfaren personal, brist på utbildning	Påverkar kvaliteten i vården
	Kvalitet i omsorg	Kontinuitet, patientsäkerhet	Hur vården påverkas
Strukturella och politiska faktorer	Demografi	Fler äldre, färre i arbete	Långsiktiga samhällsproblem
	Politisk styrning	Resursfördelning, mål	Hur politiska ambitioner påverkar verksamheten